国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

医学伦理学

Medical Ethics

第6版

主　编｜宫福清
副主编｜曹永福　邓　蕊

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

医学伦理学

Medical Ethics

第6版

主　　编｜宫福清
副 主 编｜曹永福　邓　蕊
数字主编｜曹永福
数字副主编｜邓　蕊　董园园

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

医学伦理学 / 宫福清主编. -- 6 版. -- 北京：人民卫生出版社，2025. 5. --（全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）. -- ISBN 978-7-117-37677-8

Ⅰ. R-052

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025WU3898 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

医学伦理学

Yixue Lunlixue

第 6 版

主　　编：宫福清
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编：100021
E - mail：pmph @ pmph.com
购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：人卫印务（北京）有限公司
经　　销：新华书店
开　　本：850 × 1168　1/16　　印张：14
字　　数：414 千字
版　　次：1999 年 8 月第 1 版　　2025 年 5 月第 6 版
印　　次：2025 年 6 月第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-37677-8
定　　价：58.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委（以姓氏笔画为序）

邓　蕊　山西医科大学
巩守平　西安医学院
刘俊荣　广州医科大学
杨　阳　大连医科大学
吴雪松　哈尔滨医科大学
张　珊　陆军军医大学
陈　化　南方医科大学
陈　旻　福建医科大学
陈士福　山东第一医科大学
宫福清　中国医科大学
袁蕙芸　上海交通大学
郭玉宇　南京医科大学
曹永福　山东大学
常运立　海军军医大学
梁　莉　承德医学院
董园园　中国医科大学
魏　琳　西安交通大学

编写秘书 董园园（兼）

数字编委

新形态教材使用说明

新形态教材

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

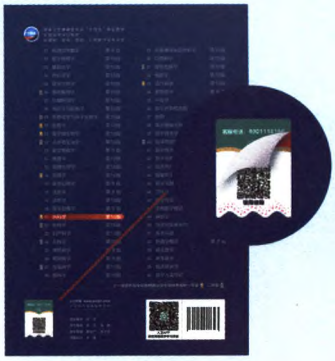
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1. 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2. 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3. 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4. 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量，

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长



2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主编简介



宫福清

男，1967 年 3 月生于辽宁宽甸。博士，教授，博士研究生导师。曾任中国医科大学党委书记、中国高等教育学会大学文化研究分会副理事长、教育部高等学校医学人文素养与全科医学教学指导委员会委员、中国自然辩证法研究会医学哲学专业委员会常务理事、辽宁省医学会医学伦理学分会主任委员。

从事医学伦理学、医学人文学领域的教学研究工作 28 年。主持国家社会科学基金项目 2 项，主持全国教育科学“十一五”国家级规划课题、辽宁省高等教育本科教学改革项目等课题 20 余项。研究成果荣获国家级教学成果奖二等奖 2 项、辽宁省教学成果奖一等奖 3 项，获辽宁省哲学社会科学奖·成果奖一等奖、二等奖多项。在国内外 SCI、CSSCI 等核心期刊发表论文 50 余篇。担任《医学伦理学》《医学人文导论》《医学人文精神培育导论》等 5 部教材及专著主编，担任多部教材及专著副主编。

副主编简介



曹永福

男，1968 年 4 月生于山东诸城。医学博士，山东大学教授。兼任中华医学会医学伦理学分会副主任委员、秘书长，中国自然辩证法研究会医学哲学专业委员会常务委员、生命伦理学专业委员会委员，国家医师资格考试医学人文试题开发专家委员会委员，山东省公共卫生学会医学伦理学分会主任委员，山东省伦理学会常务委员。《中国医学伦理学》杂志副主编、编委，《医学与哲学》杂志编委。

主持各类科研、教研课题多项。获国家级精品课程和资源共享课建设立项。主持建设“医学伦理学”“生命伦理学：生命医学科技与伦理”“临床伦理与科研道德”等线上课程，后两者分别被评为国家线上一流课程和全国医学专业学位研究生在线示范课程。发表学术论文百余篇，多篇被 SCI、SSCI、CSSCI 和人大复印报刊资料全文收录。出版专著、主编国家规划教材多部，担任多部著作、教材编委。多项研究成果获省部级奖励。



邓　蕊

女，1978 年 2 月生于山西乡宁。哲学博士，教授，博士研究生导师。现任山西医科大学人文社会科学学院院长。兼任中华医学会医学伦理学分会常务委员、医学伦理教育教学组组长，山西省医学会医学伦理学专业委员会主任委员。山西省宣传文化系统“四个一批”人才，山西省学术技术带头人。

从事医学伦理学教学工作 21 年。主持教育部及山西省科学技术厅、教育厅、宣传部科研课题 50 余项，发表论文 80 余篇，荣获山西省社会科学研究优秀成果奖二等奖等 20 余个奖项。主编国家级规划教材 1 部，作为副主编参编国家级规划教材 3 部，作为编委参编国家级规划教材 15 部。

前言

为全面贯彻党的二十大报告提出的“落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针，体现教育必须为人民服务的精神，编写适应新时代医学生科学精神和人文精神培养的高质量教材，2023年5月，《医学伦理学》（第6版）修订工作正式启动。

《医学伦理学》（第6版）修订的总体指导原则如下：一是全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）为指导，深化医学教育机制体制改革。二是以医学伦理素质的培育为出发点，以自觉医学伦理意识的形成为落脚点，注重知识、能力、素质协同提高，指导医学生正确认识、处理医疗卫生领域中的伦理问题，达到从认知、认同到践行的目的。三是反映执业医师考试大纲要求并与其相匹配、相协调，基本知识点涵盖国家医师资格考试现行大纲要求。四是准确把握五年制基础、临床、预防、口腔医学类专业的培养目标，坚持“三基”“五性”和“三特定”的教材编写原则。

《医学伦理学》（第6版）修订工作的总体思路为“强化时代特征、明确育人目标、突出实践特性”。坚持正确方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。围绕医学科学技术发展的实际问题，准确反映医学伦理学的理论与实践，着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的医学伦理学理念、主张、方案，使医学伦理学中国化与国际化、传统性与前沿性相统一。这既是第6版《医学伦理学》教材的编写特色，也是重要的更新内容。

《医学伦理学》（第6版）具体修订情况为：在原有篇幅的基础上，重新讨论并调整了大纲和编写内容，将上版教材的十八章调整为十七章，将临床特殊科室伦理的内容并入了第八章“临床诊疗伦理”，将卫生保健制度及改革伦理并入了第十五章“医院管理与卫生政策伦理”，将“医学道德规范”和“医学伦理原则”分为两章详细阐述。各章节也根据学科发展和知识更新相应有所调整，新增包括医社关系伦理、积极生育观、涉及人的生命科学和医学研究、科技伦理治理，以及医用人工智能、医疗大数据伦理等智慧医疗相关内容。

同时，本版教材为纸数融合新形态教材，为方便读者“教”与“学”，同步更新了数字资源，包括教学课件、自测题等，扫描二维码即可获得。山东大学曹永福教授负责数字资源的主编工作。

由于编写时间紧迫，编者水平有限，难免有疏漏、不妥之处，请各位读者批评指正！

宫福清

2024年12月

目录

第一章 绪论 1

第一节 伦理学概述 1
一、道德与伦理 1
二、伦理学 2
第二节 医学伦理学概述 3
一、医学伦理学的含义 3
二、医学伦理学的研究对象 3
三、医学伦理学的研究内容 3
第三节 医学伦理学的学科属性 5
一、医学伦理学的学科特征 5
二、医学伦理学学科成熟的标志 6
三、医学伦理学与相关学科的关系 6
第四节 学习医学伦理学的意义和方法 8
一、学习医学伦理学的意义 8
二、学习医学伦理学的方法 9

第二章 医学伦理思想的产生与发展 10

第一节 古代医学伦理思想 10
一、古代医学伦理思想概况 10
二、古代医学伦理思想特征 12
三、古代医学伦理思想的局限性 13
第二节 近代医学伦理思想 14
一、近代医学伦理思想概况 14
二、近代医学伦理思想特征 16
三、近代医学伦理思想的局限性 16
第三节 现代医学伦理思想 17
一、现代医学伦理思想概况 17
二、现代医学伦理思想特征 19
三、现代医学伦理思想的争鸣与发展趋势 20

第三章 医学伦理学的理论基础 21

第一节 生命伦理观 21
一、生命神圣论 21
二、生命质量论 22

三、生命价值论 …… 22
第二节 死亡伦理观 …… 23
一、中西方死亡文化 …… 23
二、科学的死亡伦理观 …… 23
第三节 健康伦理观 …… 24
一、健康与大健康 …… 24
二、健康权利 …… 25
三、健康责任 …… 26
第四节 道义论 …… 26
一、道义论的内涵与特点 …… 26
二、道义论在医学实践中的运用 …… 27
三、道义论的评价 …… 27
第五节 后果论 …… 28
一、后果论的内涵与特点 …… 28
二、后果论在医学实践中的运用 …… 29
三、后果论的评价 …… 29
第六节 美德论 …… 30
一、美德论的内涵与特点 …… 30
二、美德论在医学实践中的运用 …… 31
三、医学美德论的评价 …… 31

第四章 医学道德规范 33

第一节 医学道德规范的概念及分类 …… 33
一、有义务做某事和强迫做某事 …… 33
二、道德义务与法律义务的异同 …… 33
三、医学道德规范的分类 …… 34
第二节 国际代表性的医学道德规范文件 …… 34
一、《希波克拉底誓言》 …… 35
二、《日内瓦宣言》 …… 35
三、《国际医学伦理准则》 …… 35
四、《新世纪的医师职业精神——医师宣言》 …… 37
第三节 中国医学道德规范 …… 37
一、《中国医学生誓言》 …… 37
二、《中国医师道德准则》 …… 38
三、《医疗机构从业人员行为规范》 …… 38

第五章 医学伦理原则 41

第一节 医学伦理原则概述 …… 41
一、医学伦理原则的含义 …… 41
二、医学伦理原则产生的背景 …… 41
第二节 我国医学道德基本原则 …… 43

一、社会主义医德基本原则的内容 43
二、社会主义医德基本原则在新时代卫生工作方针中的新体现 43
第三节 国际医学伦理基本原则 44
一、尊重原则 45
二、不伤害原则 47
三、有利原则 48
四、公正原则 48

第六章 医疗人际关系伦理 50

第一节 医患关系伦理 50
一、医患关系的含义及模式 50
二、医患双方的权利和义务 52
三、和谐医患关系的构建 56
第二节 医际关系伦理 57
一、医际关系的含义及模式 58
二、和谐医际关系的构建 59
三、协调好医际关系的意义 61
第三节 医社关系伦理 61
一、医社关系的含义 62
二、医学职能的社会化 63
三、医社关系的理想模式 63

第七章 公共卫生与疾病防控伦理 65

第一节 公共卫生伦理 65
一、公共卫生工作的性质与特点 65
二、公共卫生工作的伦理矛盾与伦理原则 66
三、突发公共卫生事件伦理 68
第二节 传染病防控伦理 69
一、传染病的含义 70
二、传染病的防控内容 70
三、传染病防控的伦理要求 70
第三节 慢性病、职业病和地方病防控伦理 71
一、慢性病的防控伦理 72
二、职业病的防控伦理 73
三、地方病的防控伦理 74

第八章 临床诊疗伦理 76

第一节 临床诊疗伦理概述 76
一、临床诊疗伦理原则 76

二、特殊诊疗伦理问题 77
第二节 临床诊断伦理 82
一、问诊的伦理要求 83
二、体格检查的伦理要求 83
三、辅助检查应用的伦理要求 83
第三节 临床治疗伦理 84
一、药物治疗的伦理要求 84
二、手术治疗的伦理要求 85
三、心理治疗的伦理要求 85
四、康复治疗的伦理要求 87
第九章 生育政策与生殖技术伦理 89
第一节 生育政策伦理 89
一、生育政策概述 89
二、生育控制措施伦理 90
三、生育控制伦理原则 91
第二节 优生优育伦理 92
一、优生及其伦理价值 92
二、优生措施及其伦理 92
第三节 辅助生殖伦理 94
一、辅助生殖技术概述 94
二、辅助生殖技术的伦理价值 95
三、辅助生殖技术引发的伦理争议 96
四、辅助生殖技术应用的伦理准则 97
第十章 死亡伦理 100
第一节 死亡标准伦理 100
一、死亡的概念 100
二、死亡的标准 100
三、脑死亡标准的伦理价值和意义 101
第二节 安乐死伦理 102
一、安乐死概述 103
二、安乐死的伦理争议 105
第三节 安宁疗护伦理 106
一、安宁疗护概述 106
二、安宁疗护的伦理意义 107
三、安宁疗护的伦理要求 108
第十一章 人体器官捐献和移植伦理 110
第一节 器官移植概述 110

一、器官移植的含义 …… 110
二、器官移植的历史与现状 …… 110
第二节 人体器官捐献和移植的伦理问题 …… 111
一、移植技术的伦理问题 …… 111
二、器官来源的伦理问题 …… 112
三、器官分配的伦理问题 …… 114
第三节 人体器官捐献和移植的伦理规范与原则 …… 115
一、人体器官捐献和移植现行国际伦理规范 …… 115
二、我国人体器官捐献和移植的法律与伦理规范 …… 116
三、我国人体器官捐献和移植的伦理原则 …… 118

第十二章 前沿医学技术伦理 122

第一节 基因伦理 …… 122
一、基因技术的生命伦理审视 …… 122
二、基因诊断伦理 …… 124
三、基因治疗伦理 …… 125
四、基因编辑伦理 …… 126
第二节 人类干细胞研究与应用伦理 …… 127
一、人类干细胞研究概述 …… 127
二、人类干细胞临床前研究伦理 …… 128
三、人类干细胞临床试验及其应用伦理 …… 129
第三节 智慧医疗伦理 …… 131
一、智慧医疗 …… 131
二、“互联网+医疗健康”伦理 …… 132
三、医用人工智能伦理 …… 134

第十三章 医学科研伦理 136

第一节 科研诚信与医学科研人员道德规范 …… 136
一、医学科研中的矛盾冲突 …… 136
二、医学科研中的学术不端行为 …… 137
三、医学科研人员的道德规范 …… 139
第二节 涉及人的生命科学和医学研究伦理 …… 139
一、涉及人的生命科学和医学研究概述 …… 139
二、涉及人的生命科学和医学研究中的伦理问题 …… 140
三、涉及人的生命科学和医学研究伦理原则 …… 141
第三节 动物实验伦理 …… 143
一、动物实验概述 …… 143
二、动物实验的伦理观点 …… 144
三、动物实验的伦理原则 …… 145

第十四章　医学伦理委员会及科技伦理治理　147

第一节　医学伦理委员会概述　147
一、医学伦理委员会的起源及其历史发展　147
二、医学伦理委员会的组成与分类　148
三、医学伦理委员会的职能与运行　150
第二节　科技伦理治理　150
一、科技伦理治理的核心要义　151
二、科技伦理原则　152
三、科技伦理治理体系　153
第三节　医学伦理审查　154
一、医学伦理审查的适用范围　154
二、医学伦理审查的程序　154
三、医学伦理审查的主要内容　156
四、医学伦理审查的监督管理　159

第十五章　医院管理与卫生政策伦理　161

第一节　医院管理伦理　161
一、医院管理的概念　161
二、医院管理中的伦理问题　162
三、医院管理伦理要求　164
第二节　卫生保健制度伦理　166
一、卫生保健制度概述　166
二、卫生保健制度中的核心伦理价值　166
三、国际上典型卫生保健制度模式的伦理评价　168
第三节　我国医药卫生体制改革伦理　169
一、医药卫生体制改革的背景与历程　170
二、医药卫生体制改革的主要内容　171
三、医药卫生体制改革中的政府责任　172

第十六章　医学伦理决策　176

第一节　医学伦理决策概述　176
一、医学伦理决策的概念　176
二、医学伦理决策的具体过程　177
三、医学伦理决策的模式化　179
四、医学伦理决策的条件准备　179
第二节　普通医学伦理问题的决策　180
一、普通医学伦理问题决策的概念　180
二、普通医学伦理决策的影响因素　180
三、正确进行普通医学伦理决策　181

第三节　医学伦理难题的决策 182
一、医学伦理难题决策的概念 182
二、医学伦理难题的形成原因 183
三、顺利进行医学伦理难题决策 184

第十七章　医学道德素质的养成 187

第一节　医学道德素质 187
一、医学道德素质的含义 187
二、医学道德素质的价值 188
三、医学道德素质的养成途径 189
第二节　医学道德教育与修养 189
一、医学道德教育与修养的含义 189
二、医学道德修养的目标和境界 190
三、医学道德教育与修养的过程 191
四、医学道德教育与修养的方法 192
第三节　医学道德评价 194
一、医学道德评价的概念 194
二、医学道德评价的标准与依据 194
三、医学道德评价的方式与方法 196

推荐阅读 198

中英文名词对照索引 199

第一章 绪 论


本章数字资源

医学伦理学（medical ethics）是指在系统考察医疗卫生健康领域道德现象的基础上，依据伦理学理论，确立医学伦理的基本原则和准则，形成伦理分析框架并用其指导相应的医学道德实践，研究具体医学伦理问题的一门学科。它属于应用伦理学，也是医学人文的重要组成部分。本章首先介绍道德、伦理等基本概念，然后就医学伦理学的含义、研究对象、研究内容等进行简要介绍，讨论医学伦理学与相关学科之间的关系，探讨学习医学伦理学的意义和方法。

第一节 | 伦理学概述

伦理学是将道德问题作为研究对象的学科，一般认为，古希腊哲学家苏格拉底（Socrates）是伦理学的奠基人。不同国家和地区的伦理学家们，对伦理思想有不同的见解和认识，这些思想逐渐发展并融入伦理学理论之中，成为伦理学的重要组成部分。

一、道德与伦理

（一）道德的含义

马克思主义伦理学认为，道德（morality）是人们在社会生活实践中形成并由经济基础决定的，以善恶作为评价标准，以社会舆论、传统习俗和内心信念作为评价方式，调节人与人、人与社会、人与自然之间的关系，并追求自身人格完善的行为规范的总和。

从词源来说，“道”和“德”在古汉语中是分别出现的，是两个不同的词语。“道”的本义为道路，后来引申出反映客观规律性的道理、法则、规范等含义；“德”的本义为“得”，按照《说文解字》“外得于人，内得于己”的说法，“德”专指人们应遵从人伦之道而形成的德行、德性、品德、美德等。“道”与“德”二字连用始于《荀子·劝学》，“故学至乎礼而止矣，夫是之谓道德之极”，指学习做人做事，如果一切行为都符合礼的标准，就达到了道德的最高境界。在西方古代文化史的研究中，英文的“道德”（morality）一词源于拉丁文 mores，统指社会生活中的道德风俗和个体的德性，含有从外在的风俗习惯发展为内在品格的意思。

道德作为一种社会现象，一方面同政治、法律、宗教等上层建筑一样，本质是一定社会经济关系的产物，既受社会存在的制约又具有相对的独立性；另一方面，道德还表现出极强的实践性和内在的规范性，这种内化的规范和实践精神，构成了道德的特殊本质。

（二）伦理的含义

同样，古汉语中“伦”与“理”也是分开使用的。“伦”的本义为辈分、人伦，“理”的本义为玉石的纹理。“伦理”一词始见于战国至秦汉时期的《礼记·乐记》：“乐者，通伦理者也。”《说文解字》解释说，“伦，从人，辈也，明道也”，意思就是，伦即人伦，是合理的人际关系。伦理即人伦之理，是调整人伦关系的条理、道理、准则。在西方，伦理（ethic）源于古希腊文 ethos，原意为公共场所和驻地，后来指外在的风俗、习惯以及内在的品行、品德。

在日常生活中，“道德”和“伦理”时常被视为同义词，共同表达了“行为应该如何”的含义，但二者存在一定的差别。道德侧重于个体，更强调内在操守方面，指主体对道德规范的内化和实践，即主体的德性和德行；伦理则侧重于社会的伦理关系与秩序，关注的是社会共同价值观的建构和实践。

NOTES

道德日趋私人化，伦理日趋法律化。但无论道德还是伦理，都是以善为终极目标。

二、伦理学

（一）伦理学的含义

伦理学（ethics）是研究道德现象的学科，亦称道德哲学。在系统反思人类道德生活的基础上，伦理学逐渐形成了一套关于善恶、义务、权利、价值等范畴和概念的体系，实现了对道德观的理论化和系统化。例如，古希腊亚里士多德（Aristotle）将伦理学视为一门关于人的道德品性的学问，《尼各马可伦理学》系统阐述了“德性在于合乎理性的活动”等观点，被后人认为是伦理学学科建立的标志。当代的伦理学更是致力于建构一套包括原则、准则或规则在内的道德规范体系，并通过分析和评判现实生活中涉及该与不该、正当与否、善与恶以及对与错的社会实践情况，进而指导人们的社会行为，协调人与人、人与自然、人与社会等各种伦理关系。

（二）伦理学的类型

一般来说，伦理学按照其研究内容和方法的不同，可分为规范伦理学、元伦理学、描述伦理学、美德伦理学四种类型。

规范伦理学（normative ethics）是指通过对人类行为的善恶价值分析，研究道德的起源、本质和发展规律等，试图从哲学上形成和论证道德原则和规范，以约束和指导人们的道德实践的伦理学。它主要回答下列问题：什么样的行为是善的或恶的？人们作出该与不该、正当与否之类判断的标准是什么？如何构建出一套逻辑自洽的指导和评价人的行为的道德规范？如何论证这些规范的完整性和合理性？

元伦理学（meta-ethics）主要分析伦理学术语、概念以及伦理推理方法。元伦理学对道德话语研究或分析的重点集中于道德的语言分析和逻辑推理。元伦理学研究价值、善、应该、正当、是和事实等概念，以及道德推理和确认等方面的问题。它不制定道德规范和价值标准，对任何道德规范、价值都采取中立立场。

描述伦理学（descriptive ethics）是关于道德行为和信念的事实性研究，侧重于对具体历史文化背景下的社会伦理现象、社会公众日常道德生活进行直观描述。它既不涉及行为的善恶及其标准，也不寻求制定行为的准则或规范，只是对道德现象进行经验性描述和再现。

美德伦理学（virtue ethics）是指研究优良道德如何实现，以道德行为主体及其品德、美德为研究内容的伦理学，认为一个人只要拥有适宜的美德，自然就会作出好的道德判断，即作出合乎伦理的行为决策、评价和辩护。

20世纪60—70年代，当代英美哲学家从单纯的理论构造和规范论证转向道德实践，提出应用伦理学（applied ethics），把它看作与元伦理学和规范伦理学并列的伦理学分支学科。应用伦理学不再集中于逻辑分析和语言分析，转而注重现实问题，研究规范的落实，标志着伦理学研究方法和研究范式的应用转向。一般认为，医学伦理学及生命伦理学是发展得比较完善的应用伦理学学科。此外还包括司法伦理、教育伦理、环境伦理、生态伦理、经济伦理等。

（三）伦理学的研究对象

伦理学的研究对象是道德现象，包括处理人际关系的道德规范、指导日常行为的道德品质、社会生活中人的德性和德行，揭示道德现象的本质及其规律等。伦理学一方面研究涉及人生的根本性和总体性问题，包括人的本性和人性、人的价值和尊严、人的目的和追求，终极使命是什么等；另一方面研究如何使人生活得更好，如何使社会秩序更为合理，如何处理个人与他人、个人与社会、人类与自然之间的关系问题等。

（四）伦理学的基本理论

人们在进行道德判断时，或依据行为者的动机，或依据行为者可能或实际造成的结果，或根据行为者本身，形成了伦理学的三个基本理论，包括道义论、效果论和美德论。道义论也称“义务论”，要

求人们的行为必须按照某种道德原则或按照某种正当性去行动的道德理论，强调道德义务和责任的重要性，它与效果论是对立的。效果论又称后果论、目的论或功利论，最有影响的代表人物是英国的边沁（Bentham）和密尔（Mill），以功利和行为所产生的效果来衡量什么是善，什么是最大的善的问题，并依此判断行为的道德性。美德论则以品德、美德和行为者为中心，研究和探讨人应该具有什么样的道德品质，有道德的人是什么样的人，人应该具有什么样的品德或品格。

伦理学基本理论是医学伦理学得以构建的理论基石，中外哲学史上很多优秀的人类思想成果，都为医学伦理学的理论构建和创新发展提供了重要理论来源。中华优秀传统文化以及中国的哲学社会科学理论也影响了中国医学伦理学的发展。

第二节 | 医学伦理学概述

医学伦理学涉及医学和伦理学两个学科，是两者交叉融合的结果，是用伦理学的理论、原则来研究、指导医学领域的道德现象、道德关系、道德问题和道德建设的一门科学。医学伦理学属于应用伦理学的范畴，随着越来越多人开始关注医学中的人文问题，作为医学人文重要内容的医学伦理学，也日益被人们关注。

一、医学伦理学的含义

医学伦理学（medical ethics）是研究医学道德现象的学科，是医学与伦理学的交叉学科。一方面，医学伦理学是规范伦理学在医疗卫生领域中的具体应用，即运用一般规范伦理学的理论和方法来分析和解决医疗卫生实践和医学科学发展中的多种道德问题，属于应用规范伦理学；另一方面，随着人们对医学认识的不断深入，医学的人文属性日益受到关注。医学人文已经成为医学学科群的一个分支。医学伦理学作为医学人文的重要内容，已经融入医学专业教育之中，成为医学院校的基础课程之一。

二、医学伦理学的研究对象

医学伦理学以医疗卫生健康领域和医学科技实践中的道德现象及其道德关系为主要研究对象。

医学道德现象是医疗卫生健康领域和医学科技实践中存在的且能够被人们感知的具有善恶、正邪、荣辱等评价意义的社会现象的统称。它包括医学道德的意识现象、规范现象和实践现象等。医学道德意识现象是指医务人员在处理医学道德关系实践中表现出来的行为态度、伦理思想、道德观念和伦理学说的总和。医学道德规范现象是评价医务人员行为的道德标准，是判断医学道德活动善恶、荣辱、正义与非正义的行为准则。医学道德实践现象是指在医疗卫生领域中，人们按照一定伦理理论和善恶观念而采取的道德行为或行动的总和。医师要有心系患者、爱岗敬业、勇攀高峰的精神风貌，形成无私奉献、救死扶伤的坚定信念，坚守精诚为业、仁爱为医的高尚医德，弘扬精益求精、一丝不苟的敬业精神，践行患者为本、敬畏生命、坚持人道主义的医师准则，努力做全心全意为人民群众健康服务的好医师。

医疗卫生健康领域和医学科技实践中的道德关系至少包括如下方面：①人与人之间的关系，如医患关系、医医关系、医护关系；②人与组织之间的关系，如医务人员与医疗机构及其科室之间的关系；③组织之间的关系，如医联体内部大医院和社区卫生服务中心之间的关系，医疗机构与卫生行政部门的关系；④人、医疗机构与社会之间的关系；⑤人与自然环境之间的关系。这些关系总是受社会历史条件、经济制度和经济条件的制约，受社会风俗习惯的影响，受文化礼仪规则的限制，受民族、职业、宗教、道德乃至性别等因素的约束。医学伦理学通过一系列的道德规范来调节这些道德关系，以及规范医务人员的医疗行为。

三、医学伦理学的研究内容

作为医学人文学科群的一门主干学科，医学伦理学的研究内容主要包括：医学伦理学的基本理

论、基本原则、基本规范和范畴；预防医学、临床医学、医学科研、医院管理、卫生经济与医疗保健政策等领域具体的伦理问题；医学道德决策、教育、修养及评价监督，医学专业精神等。

（一）医学伦理学的理论

医学伦理学的理论包括医学道德的本质属性、发展规律、产生及历史发展、理论基础等，其中理论基础包括两部分。第一部分是三大类基本观点：第一类是生命观，是指人类对生命的道德观点和态度，包括生命神圣论、生命质量论和生命价值论；第二类是死亡观，指人们对于死亡的根本观点和态度，包括传统死亡观和现代科学的死亡观，受传统观念影响，中西方的思想家都对这一问题有着大量的思考成果；第三类是健康观，是指人们对健康的整体看法，《“健康中国 2030”规划纲要》特别强调以预防为主的“全民健康”和“人人健康”理念，这也是全面推进健康中国建设与健康伦理实践的核心和价值主旨。第二部分是三个基本理论，即道义论、效果论和美德论。

（二）医学伦理学的基本原则、规范、范畴

医学伦理学作为应用伦理学，无疑更应该注重规范的研究和确定，不仅要研究一般道德规范，借鉴和吸收历史的经验，继承和发扬优良道德，还要研究医学不同学科及医学专业不同分工中的具体规范和要求，以阐明医疗实践中不同行为主体应承担的道德责任，指出从事医疗实践过程中应遵循的道德原则，并将其作为医务人员医疗实践的出发点，作为评价医学行为道德与否的伦理标准。

医学伦理原则并不是对一般伦理学原则的简单应用，它具有自身的特殊性。这种特殊性源于医学实践的特殊性，即直接关系到人的生命健康和安全。1941 年，毛泽东为中国医科大学的毕业生亲笔题词“救死扶伤，实行革命的人道主义”，成为贯穿于我国医疗卫生工作方针中的一种鲜明的医学道德精神和原则。2016 年，习近平总书记提出新时代中国卫生与健康工作方针，“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”成为新时代医德精神。2020 年 5 月 22 日，习近平总书记在参加第十三届全国人民代表大会第三次会议内蒙古代表团审议时发表重要讲话，提出“人民至上，生命至上”，成为卫生健康服务的重要指导原则。这些指导方针和指导原则的提出体现了我国医学伦理原则的基本宗旨，把人民健康作为一切工作的中心和一切工作的最高价值。

面对医学发展带来的一系列问题，西方学者提出了一些较具影响的伦理原则，推进了医学伦理原则的国际探讨，如《贝尔蒙报告》（*The Belmont Report*）的三原则说，即尊重人（respect for persons）、有利（beneficence）、正义（justice）三个伦理原则；美国生命伦理学家恩格尔哈特（Engelhardt）的二原则说，他认为允许（允诺）和行善两个原则，应作为生命伦理的基本原则；得到更多认可，影响比较广泛的是美国学者比彻姆（Beauchamp）和邱卓思（Childress）合著的《生命医学伦理原则》（*Principles of Biomedical Ethics*），该书提出了四原则说，包括尊重原则、不伤害原则、有利原则、公正原则。

医德规范不是随意制定或约定的，也不是从特定社会文化中抽象的伦理原则中演绎推导出来的，而是在对人类社会长期道德实践活动的理性反思基础上概括总结出来的。要形成原则，必须描述分析已有的规范、规则、范畴，根据医学道德的普遍性与特殊性关系，得出其中的伦理原则，然后再确立适应医学伦理学发展和需要的医学道德规范。

（三）医学伦理实践

医学伦理实践，主要包括医学伦理决策和辩护、医学道德评价、医德教育和修养、医学职业精神提升等实践活动。社会确定的医学伦理原则、规范等往往是外在的、客观的道德要求，其价值得以体现和实现，必须转化为医务人员内在的、主观的自身信念。这个任务是复杂的、具体的、丰富的，主要通过医学伦理实践完成。医学伦理学的学科知识体系随着新兴科学技术的发展，也在不断演化和完善。

（四）医学伦理难题与医学伦理决策

医学和生命科学的长足发展以及社会道德的进步，在医学实践领域引发了一系列利弊难以权衡的困境，又被称为医学伦理难题或者医德两难抉择问题，这些难题是指在特定境遇下医疗行动选择上存在的两个或多个道德理论、原则之间的冲突，迫使道德选择主体必须选择其中一个理论或原则，同

时必须放弃另一个理论或原则。在选择做什么或不做什么的时候，不仅是在相对简单地作出善或恶的选择，还要做更为复杂的价值选择，即进行利与弊、善与恶大小多少的比较，以求正面结果最大化，负面结果最小化，因其往往还没有或难以找到现成的标准答案，从而导致选择者处于左右为难、进退维谷的窘境。

根据医疗卫生健康领域的不同，医学伦理问题可以分为如下几大类：

（1）临床伦理问题：临床诊疗中存在的伦理问题。如医学干预中如何保护患者的自主权；如何贯彻知情同意，使患者和家属更好参与临床决策；如何处理医务人员之间的利益冲突或义务冲突；如何定义过度医疗等。

（2）医学研究伦理问题：涉及人的生命科学和医学研究要保护研究参与者的正当权益，做到知情同意、隐私保护，注意风险-受益比、公平选择等问题，科研人员应该自觉遵守伦理准则，清楚伦理审查的程序和要点。

（3）新兴生物医药技术伦理问题：进入21世纪，基因编辑技术、基因治疗、胚胎干细胞研究、器官移植技术、合成生物学、再生医学引发了诸多新的伦理问题，如基因治疗是否加剧稀缺医疗资源的分配不公？是否应该告知家庭成员重要的基因检测信息？

（4）公共卫生伦理问题：如分级诊疗中是否尊重了患者自主选择就诊医疗机构的意愿；在保护个人、遵守医院规定和保证患者安全之间如何权衡；在突发重大疫情救助现场，如何决定稀缺医疗资源分配的优先次序；重大医疗救护中限定个人自由能否得到伦理辩护等。

这些医学伦理问题呈现出如下特点：第一，复杂性。医学伦理问题往往与社会、法律、宗教、哲学等问题相互交织。第二，客观性。医学伦理问题是客观存在的，植根于社会文化和医疗卫生实践之中。第三，多样性。在常规临床操作、医学科研和高新技术应用中所引发的伦理问题的表现和根源不同。

只有根据现有的伦理基本理论和原则，通过伦理分析或论证，找到问题的本质或根本原因，才能提出可行性决策。基于不同医学道德规范，不同的医务人员可能会形成相互冲突的不同医学伦理行为方案。面对这些医学伦理决策难题，需对不同方案的道德价值进行比较和权衡。伦理权衡的基本原则是：两害相权取其轻，两利相权取其重。临床决策需要充分考虑患者及家属的价值观，鼓励患者参与临床共同决策。为此，医务人员要加强个体道德修养，接受伦理教育，培养医学伦理决策能力，树立正确的医学伦理价值观，弘扬医学职业精神。

第三节 | 医学伦理学的学科属性

医学伦理学是一门综合性、交叉性的学科，它融合了医学、伦理学、哲学、法学等多学科的知识，是一门既具有科学性又具有人文性的学科。它不仅是应用伦理学的分支学科，也是人文医学学科的重要组成部分。

一、医学伦理学的学科特征

医学伦理学主要有以下几个学科特征。

1. 科学性 医学伦理学是对医学道德的本质、规律等的普遍性和必然性的研究。医学的科学与道德须臾不可分离。“医乃仁术”，善是医学的本质属性。医学伦理学具有系统的思想观点和理论形式，用科学的方法和理念客观地反映事实，直面矛盾，追求真理，经受得住历史和实践检验的规律性认识。人们开展医学科研、临床诊疗等实践活动都必须遵循医学道德原则和准则。

2. 人文性 医学是为实现减轻人类病痛的最初意愿而诞生的，医学发展史就是人们为消除病痛、重获健康而不断辛勤求索的历史，对生命的关爱、对健康的追求始终是医学的目标和宗旨。东西方的医学体系在漫长的医学实践与科学探索中，达成了高度共识：医者，不仅要技艺精湛，更需有人文

精神。医学伦理是医学人文的核心，以关爱患者、敬畏生命为核心的医学人文精神是医学赖以产生、存在和发展的重要精神支柱。

3. 规范性 医学伦理学不仅研究医学实践中的现象和存在的伦理问题，也对医学实践中应该遵循的道德原则和准则进行系统研究。这些原则和准则是在医学科学尤其是生命科学的发展和实践基础上，经过广泛的讨论和论证而形成的，具有普遍的适用性和约束力。

4. 交叉性 医学伦理学是一门跨学科的学科，它涉及医学、伦理学、哲学、法学等多个学科的知识和理论，医学伦理学的价值就在于综合运用这些学科的知识和理论，更好地解决医学实践中存在的伦理问题和挑战。

5. 实践性 医学伦理学是一门实践性很强的学科，它不仅需要理论探索和研究，需要在医学实践中不断得到应用和检验，更好地指导医学实践，而且还需要医务人员不断践行医学道德。

综上所述，医学伦理学是一门具有科学性、人文性、规范性、交叉性和实践性等特征的学科，这些特征使得医学伦理学在医学领域和社会道德体系中都具有重要的地位和作用。

二、医学伦理学学科成熟的标志

医学伦理学学科已经日臻成熟，有着丰富的理论资源、公认的伦理原则和规则，各分支学科快速发展。

1. 拥有丰富的伦理学理论资源 伦理学源远流长，流派众多，影响着每一个时代的道德生活，也成为了医学伦理思想的文化底蕴与深厚根基。德性论、义务论、后果论，以及关怀主义伦理学、责任伦理学为现实的医学道德现象的识别、分析和研判提供了广阔的解释空间和针对性的伦理指导。这些丰富多元的伦理学说与鲜活的医学道德实践相结合，既有助于解决广大医务人员在日常医疗实践中遇到的伦理难题，减少道德沮丧感，也能够为医学伦理学学科建设注入强劲的动力。这些伦理学理论、原则、概念和方法借助规范化的教育培训，也培养了新一代的医学伦理学教学和科研人才，为学科发展提供了人才保障。

2. 形成了一套公认的具有操作指引的伦理原则和规则 尊重、不伤害、有利、公正等伦理原则得到国际医学伦理学界的普遍认可。这些伦理原则可以细化为某些具体临床、科研的伦理规则或准则，来指导医学人文实践。伦理规则可以分为实质规则和程序规则。实质规则是指讲真话、隐私保密、减少痛苦、提高生命质量、维护生命尊严诸如此类具有实质内容的规范；程序规则是保证实质规则实现的某些过程、步骤、机制等方面的规范。例如，医学伦理审查就是程序规则，涉及人的生命科学和医学研究应该经过伦理审查；在伦理审查中，凡是与项目有利益冲突的委员必须遵循回避制度。

3. 分支学科不断涌现 进入21世纪，医学伦理学衍生出诸如临床伦理学、护理伦理学、医学科研伦理学、公共卫生伦理学等分支学科。历史悠久的临床伦理学在医患关系、临床伦理决策、临床伦理咨询等方面成果丰硕。针对艾滋病/性病防控、突发公共卫生事件、流行病暴发等重大医疗救护的伦理反思和公共卫生伦理学等研究异军突起。21世纪初，以基因伦理学、辅助生殖伦理学、器官移植伦理学为代表的医学新技术伦理学日渐兴起。围绕着新药、新医疗器械、新疫苗临床试验和革新性疗法的快速发展，以及科研不端行为日趋凸显，医学科研伦理学快速成长。随着人口老龄化和疾病谱系的变化，人们逐渐形成健康养生概念，健康中国建设扎实、有效推进，健康伦理学等学科逐渐分化出来。

三、医学伦理学与相关学科的关系

医学伦理学与医学、哲学、法学、社会学、政策科学、心理学、语言学、文学、教育学、美学等学科均有着程度不同的关联。为此，有必要厘清医学伦理学与其他相关学科的关系，划定学科边界，明确各自的适用范围，更好地理解医学伦理学的研究内容、对象和学科地位。

1. 医学伦理学与医学 医学和伦理学是两门彼此独立的学科。医学以人的生命为研究对象，它

是研究人的生命过程以及人类同疾病作斗争、促进人类健康的一门学科；医学伦理学则是揭示人们在探索人类生命运动规律过程中和人类与疾病作斗争过程中相互关系的行为准则和规范的一门学科，两者彼此联系，又相互区别。

医学和医学伦理学有着天然的密切联系，二者的关系突出表现在以下三个方面。

首先，医学的本质是人学。医学目的是要预防疾病、增进健康、解除病痛、提高生命质量，因而医学充满了丰厚的人文情怀。医学是以人的生命为对象的实践活动与知识体系，因而兼有自然科学、工程技术特别是人文社会科学的特性。尤其是临床医学、公共卫生学和护理学均包含了较多的人文社会科学成分，就此而言，医学伦理学属于医学的有机组成部分。

其次，医学伦理思想来源于医疗实践。人类社会早期的医疗实践中就孕育着朴素的伦理思想，经过历史积淀和理性反思，形成道德认知和态度，进而提升为相对稳定的医学道德观念和道德规范。这样一套由多层次的道德原则和准则构成的特殊价值体系，规范着医务人员等的医疗卫生行为，引导着人们选择正当的行为，尽相应的道德义务和肩负专业职责，弘扬医学职业精神。

最后，医学伦理学需要回应医学领域各种新的伦理挑战。例如，新药随机双盲对照试验中如何保障研究参与者的权益问题，需要获得研究参与者的知情同意，公正分担负担和受益等。又如，高新技术的临床应用引发了如何合乎伦理地开展临床决策问题，这就需要探讨和实践医患共同参与临床决策的模式。

2. 医学伦理学与卫生法学 法律法规是由国家及其有关部门制定并强制实施的行为规范。道德依靠内心信念、传统习俗、思想教育、社会舆论来调节和规范人的行为。法律依靠强制性的规范来约束人的行为；道德依靠自律性的道德修养来约束人的行为。二者相辅相成，缺一不可。伦理为法律提供正当性辩护，法律又可保障伦理观念、规范的实施。

医学伦理学与卫生法学关系最为相近。卫生法学以医疗卫生领域的法律规范为主要研究对象。医学伦理学以医学道德为研究对象。医德规范与卫生法规互相联系、互相补充。医学道德规范要求的范围广，它规定了医疗卫生领域的道德底线，如：不允许克隆人，不得对人类生殖细胞系开展非医学目的的基因编辑等。医学伦理学又提倡更高的道德境界，例如科研人员和医务人员应该无私利他、自我牺牲等。

3. 医学伦理学与医学心理学 医学心理学是研究心理因素在人类疾病预防、诊断、治疗以及康复过程中发挥作用的学科。医务人员除了应具有扎实的医学基础知识和熟练的诊疗技能外，还应该熟悉患者的心理，帮助患者减轻或消除疾病带来的痛苦。医学心理学为推动医患互动和医患沟通提供了重要理论和方法依据，通过帮助医务人员掌握患者的心理特征及其活动规律，来构建和谐的医患关系。医学伦理学更加注重服务对象的身心整体，重视医德责任、医德态度、医德医风建设。医学伦理学与医学心理学是相互促进和补充的关系。大量的临床案例说明，医务人员医德高尚、关爱患者，患者才能更加信任医务人员，才能真正展开心理研究与心理治疗；而医学伦理学的发展也需要医学心理学的支持和补充。

4. 医学伦理学与医学社会学 医学社会学运用社会学的一般原理，研究医学社会问题，把医务人员和患者作为不同的社会角色，研究其与医疗卫生保健以及其他社会现象之间的关系，从总体上把握医药卫生人员与社会的关系。它还研究与健康、疾病有关的社会环境的变迁、社会结构与功能、社会对策与措施、社会控制与评价等问题。医学社会学主要运用社会调查法、非社会调查法和统计法等手段深入研究医患关系、临床伦理决策、医师的社会责任等。医学社会学重视医学的社会性质，强调医学与社会因素之间的相互作用，拓宽了医患关系的内涵，把医患关系置于广泛的社会关系网络之中。医学伦理学则运用伦理学的一般原理，着重研究医学活动中的人际关系和行为规范，并以历史与逻辑、批判与继承等方法，通过问题导向法、案例分析法、哲学思辨方法等手段，揭示医学道德的意识现象与活动现象的特点和规律，协调各种医学道德关系。

5. 医学伦理学与卫生事业管理 伦理原则或准则通常是专业人员道德职责的细化。医疗专业

人员和医学科研人员应遵循的伦理规范，有些来自医疗卫生政策或相应的指导原则。例如，当前的深化医药卫生体制改革要坚持以人为本，把维护人民健康权益放在第一位；坚持公平效率统一，政府主导与发挥市场机制作用相结合。这两个基本原则也是广大医务人员和医疗机构执业中应该遵循的基本伦理规范。

医学伦理学与卫生事业管理之间是一个双向互动过程，一方面需要使用伦理学基本理论去解释、评价具体的公共政策；另一方面伦理理论本身在政策的制定和实施过程中又要不断受到现实的检验。医学道德原则和规则的细化和实施必须考虑到相应卫生政策的可行性和有效性、社会的文化多样性、社会程序和社会公众的可接受性。医学伦理原则和规则为医疗卫生政策的评价提供了道德基础，但是政策的制定、贯彻实施和评价必须同时依靠经验数据、卫生经济学、法学、心理学等方面的知识。

此外，医学伦理学还与医学哲学、医学美学等诸多学科有着内在联系。医学哲学关于医学目的、生死观、医学模式、临床证据、临床决策、医学理论的哲学内容研究开阔了医学伦理学的视野，为学科发展提供了哲学基础。任何具有医学伦理意义的现象，一般都具有美学价值；而医学上一些具有美学意义的现象，也常蕴含医学伦理价值。梳理医学伦理学与其他相关学科之间的关系，不难发现，相关学科都会涉及医学伦理和医学道德，但只有医学伦理学将医学道德作为一个整体，全面、深入、详尽地加以系统研究。

第四节 | 学习医学伦理学的意义和方法

医学伦理学是医学与人文的交叉学科，是医学生必须学习的医学人文核心课程，是开展医学实践的基础。学习医学伦理学有助于学生增强伦理意识、维护医学目的、提高自身修养，树立正确的职业观。在学习过程中，也应该适应时代要求，知行合一，准确把握多种学习方法，提高识别和处理伦理问题的能力。

一、学习医学伦理学的意义

1. 有助于增强伦理意识，培养高尚医德 学习医学伦理学有助于医学生形成正确的价值观，增强伦理意识，培养高度的职业责任感和对患者深切的同情心。系统完整地学习医学伦理学理论、原则、规范和准则，有助于医学生自觉践行医学伦理，规范医疗实践行为，养成良好的医德品质。只有认识到持续完善自我的重要性，才能不断追求卓越，对医疗工作保持高度的职业热情，对患者保持真诚的关爱，持有医者仁心，才能不断增进医患信任，努力构建更加和谐的医患关系。

2. 有助于维护医学目的，发展医学科学事业 医学的目的是护佑生命、减轻痛苦、关爱健康。要实现这一目的，医务人员不仅需要具有精湛的医术，更需要高尚的医德、科学的思维方式和应对挑战处理危机的能力。高新技术在医疗领域的广泛应用，使得传统的医德关系、医德意识和医德规范受到了冲击，这些冲击带来了许多医学伦理问题，其中很多涉及伦理价值判断，医务人员需要掌握科学的思维方式，作出正确的道德抉择。学习医学伦理学有助于医学生在医疗实践中识别医学伦理困境，提高逻辑思辨能力，培养临床伦理决策和科研伦理审查能力，解决科学技术高速发展带来的诸多伦理难题，促进医学科学健康发展。

3. 有助于建设健康中国，提高群体健康水平 习近平总书记针对建设健康中国明确提出，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。医学不仅要增进患者的健康，还要为促进社会群体的健康与和谐发展服务。医学生学习医学伦理学，有利于保障良好的医疗秩序，在公正原则指导下合理分配有限的医疗资源，减轻人民群众的疾病经济负担，从而体现人人平等，减少社会矛盾，为社会的良性发展提供有力保障。医学生要不忘初心、牢记使命，坚持人民至上、生命至上，努力实现医术和医德的良性互动，忠诚于医疗卫生事业，积极投身于健康中国建设，争做人民群众健康的倡导者和守护者。

二、学习医学伦理学的方法

1. 以问题为导向，从实际出发进行伦理分析 学习医学伦理学最重要的是要善于发现和识别医学实践中的各种伦理问题，运用医学伦理学的基本理论、原则和具体规范，结合实际和发展动态，针对现实中的各种医学伦理问题作出科学的说明和清晰的分析，从而提出相对合理、适宜的解决办法，确定医学伦理行为方案。

2. 以案例为基础，学习理性思辨的逻辑方法 通过典型案例分析，可以模拟具体医学境遇，了解不同道德判断和道德推理的正确和失误，有助于医学生系统地理解和把握医学伦理规范体系；案例分析具有灵活、生动等特点，有利于激发学生的学习兴趣，增强其对伦理问题的敏感性；通过对话和讨论，也能碰撞出更多的思想火花。掌握并灵活运用分析与综合、归纳与演绎等逻辑思维方法，可以使医学生透过纷繁复杂的医学道德现象，由此及彼、由表及里、去粗取精、去伪存真，引导学生从正确的前提出发，发现现象背后的本质和规律。哲学的理性思辨、反思平衡等方法是学习医学伦理学的重要逻辑方法。

3. 以践行为目的，培养伦理决策能力 医疗工作具有高风险性，医学上也还有许多未知数，医师面临着前所未有的挑战，这些挑战因临床、政治、法律和市场力量的不断变化而加剧。世界医学会《国际医学伦理准则》（*International Code of Medical Ethics*，*ICoME*）（2022 年）指出，医师必须凭良心、诚实、正直和责任心执业，同时始终行使独立的专业判断并保持最高标准的职业行为。医师行医不得以牺牲环境为代价，应可持续发展，以最大限度地减少当代及后代的环境健康风险。《中国本科医学教育标准——临床医学专业（2022 版）》中关于职业精神与素养领域部分，也要求学生能够掌握医学伦理学的主要原理，并将其应用于医疗服务中。学生能够了解并遵守医疗行业的基本法律法规和职业道德。所以，医学生在学习医学伦理规范、卫生法律法规和卫生政策的同时，也要学习如何进行医学伦理决策。世界医学会的《日内瓦宣言》《赫尔辛基宣言》《国际医学伦理准则》等行为规范，可以帮助医学生不断培养自身的职业道德素养，从容应对临床实践、医学科研、高新技术应用中的棘手问题，学会做一名医德高尚、自觉遵循伦理原则的人。

思考题

1. 辨析“伦理”和“道德”的区别和联系。
2. 医学伦理学的研究内容是什么？
3. 医学伦理学的基本观点包括什么？
4. 为什么要学习医学伦理学？

（宫福清）

本章数字资源

第二章 医学伦理思想的产生与发展

医学伦理思想的形成可以追溯到古代文明时期，但其现代形式的发展主要始于20世纪中期。随着医疗技术的进步，医学实践中的道德难题日益显现，医学伦理思想的研究也日益深入，成为当代医学不可或缺的一部分。本章结合医学道德与伦理方面的人物、文献、思想、典故等，对医学伦理思想的产生与发展进行探析，以期更好地研判和应对当代医学伦理学面临的挑战。

第一节 | 古代医学伦理思想

人类社会早期，人们对生老病死等现象无法解释更无法掌控，常感到恐惧和疑惑，但解除病痛、恢复健康的人本精神与执着追求却是根深蒂固的，这种关爱患者、消除病痛的人文情怀孕育和催生了医学和医学科学。从医学的特征和发展史看，医学是仁术，具备科学和人文的显著特征，其中医学伦理思想也伴随医学的出现而不断演化。

一、古代医学伦理思想概况

远古原始的医学被称为神灵医学。人们通过祈求上天或者拜物，期盼在神灵的庇佑下战胜病魔。随着社会文明的发展进步，逐渐出现经验医学、生物医学、生物-心理-社会医学等不同医学模式，在人类历史发展的不同阶段医学伦理思想也随之呈现鲜明的时代特征。

(一) 中国古代医学伦理思想概况

中国古代医学伦理思想是中国传统文化的重要组成部分，也在中国医学发展史上占有重要地位。学习、研究中国医学伦理思想的历史可以了解不同时代背景下医学伦理发展面临的问题和应对方式。历史上的医学伦理思想成果也为解决当代医学伦理难题提供了宝贵的经验和思路。中国古代医学伦理思想的形成和发展过程主要可分为以下几个时期。

1. 萌发期 远古至殷商西周时期。中国古代医德思想在远古时代已经萌生，《帝王世纪·路史》中记载伏羲“乃尝味百药而制九针，以拯夭枉矣”。《淮南子·修务训》记载神农“尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民知所避就。当此之时，一日而遇七十毒”。这些传说，反映了古代先祖为了“拯夭枉”“令民知所避就”，不惜拿自己的生命做试验，以寻求治疗疾病的方法，蕴含着朴素的“仁爱救人”的医学伦理思想。

夏商西周时期产生了专门从事医疗工作的医师——巫医。现今发现的殷商时期的甲骨文中就有巫医及医疗活动的记载。西周时期建立了一套医政组织和医疗考核制度。对医师的考核不仅限于技术，还包括思想道德、作风、态度等方面，要求医师“忠于医业”，这些对医学科学的发展和医学伦理道德水平的提高起到了促进作用。

2. 形成期 春秋战国和秦汉三国时期。春秋战国时期，我国思想领域出现百家争鸣的局面，诸子百家代表不同阶层利益提出了各种观点学说，为古代医德思想体系的形成提供了理论支撑。儒家以“仁”为核心，提出“医乃仁术”，提倡“济世救人”“爱人、行善、慎独”；墨家提倡“兼爱互利”，令医学融入了“济群生”的思想；杨朱提出的“贵生”思想成为医学道德的核心内容，这些都为“博施济众”的医道原则提供了理论依据和思想基础。《黄帝内经》不仅是我国现存最早的医学经典著作，还是我国第一部有专门论述医学伦理道德内容的医书，它标志着我国传统医学伦理思想初步形成。

在《黄帝内经》中，《灵枢·师传》篇专门讲了医师的责任和良心，以获得患者的配合，达到治病救人的目的。《素问·征四失论》篇专门讲述医师在临床诊疗中易犯的四种失误，明确提出医家失误的原因，除了与技术水平的高低有关，还取决于工作态度，并把“精神不专，志意不理”列为失误的首要原因，强调医德的重要性。《素问·疏五过论》篇告诫医者应当避五过，从四德，只有这样才能对病者作出正确的诊断与治疗。

秦汉三国时期不仅进一步积累了许多优秀的医学伦理思想传统和道德观念，还出现许多美好的医学道德形象，例如被称为“建安三神医”之一的董奉，长期隐居庐山，为贫民治病，不取报酬，并尽力赈济贫困者，留下“杏林春暖”的佳话。这些美好医生形象的出现，代表着我国传统医学对美好品德和伦理思想的追求。

3. 发展期　魏晋南北朝至隋唐五代时期。魏晋南北朝时期，出现了王叔和、皇甫谧、葛洪、陶弘景等崇尚医德、深究医术、精勤不倦、济世救人的名医大家，他们在医术精进的同时，还践行了宽和端正的优良职业操守。

隋唐五代时期名医辈出，以孙思邈为代表的隋唐医家，融儒、释、道三家文化为一体，以尊重人和爱护人的生命为崇高的医学伦理目标，构建起中国传统医学伦理思想体系。孙思邈著有《备急千金要方》和《千金翼方》，其中的“大医精诚”和“大医习业”等篇章是医学伦理道德的专论。孙思邈认为：“人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此”，要求医者具有仁爱的“大慈恻隐之心”和“好生之德”，对患者要“普同一等”“一心赴救”。孙思邈继承和发展了我国古代传统医学，同时重视医德修养和医学伦理实践，体现了朴素的人道主义精神。

4. 完善期　两宋、金元、明代和清朝早中期。宋明时期的程朱理学和陆王心学发展了中国的儒、释、道文化。在这种文化指引下，中国传统医学进一步发展，并涌现了一大批医学大家，如“金元四大家”、李时珍等。明朝时期，我国传统的医德规范、医德教育、医德理论发展日趋完善。明代著名医家陈实功在《外科正宗》中对我国古代医学道德思想做了系统总结，归纳出“医家五戒十要”。明朝另外一位著名医家龚廷贤在著作《万病回春》中还开创性地提出了“病家十要”，对患者也提出了道德要求，进一步丰富发展了传统医德思想。

清代医学家喻昌在《医门法律》中，将临床四诊、八纲辨证论治的法则作为医门的“法”，以临床治病时易犯的错误作为医门的“律”，两者结合称为“医门法律”。《医门法律》提出了对临床医师的医疗行为进行评价的客观标准，开创了临床医德评价的先河，被后人称为“临床伦理学”，是对传统医德理论的突破，在中国古代医学伦理思想发展史上具有重要意义。

（二）国外古代医学伦理思想概况

远古时代，人们认为世间的一切是由超自然的神灵主宰，疾病乃是神灵的惩罚或者是妖魔鬼怪附身，故把患病称为“得”病，对待疾病则依赖巫术驱凶祛邪，而死亡是“归天”，是灵魂与躯体分离，被神灵召唤去了。这种把人类的健康与疾病、生与死都归之于无所不在的神灵的观念，就是人类早期的健康与疾病观，即神灵主义医学模式（spiritualism medical model）。巫医模式就是这种盛行于远古时代的，把病因归咎于某种超自然的神秘因素的医学理论以及以占卜、祭祀、祈祷等为主要医学手段的医学实践方式。

当时人们对自然的认知水平低下，对医学伦理思想的探究更多处于天、神、人、巫相互呼应的原始状态。随着人类认知水平的提高，人们开始以自然哲学理论解释健康与疾病，逐渐形成自然哲学医学模式（natural philosophical medical model）。公元前6世纪后，西医鼻祖希波克拉底的“四体液说”破除了“巫医同源”的思想，开始形成具有科学雏形的整体医学观。同时，希波克拉底在实践中身体力行，其行医格言与人文智慧作为道德准则教导后世医者规范行医。

1. 古希腊医学伦理思想　西方医学教育起源于古希腊。大约在公元前6世纪至公元前4世纪，古希腊医学形成，当时的医学教育注重医者文化素养和探索欲望的培养，有序合理地安排了德育、智能、体能、美育等不同课程。西方医德思想最早、最著名的代表人物，是被称为“西医之父”的希波克

拉底(约公元前460—前377年)。他提出了医师应当具备的美德和优良品质,建立了医师行医的行为伦理准则。

《希波克拉底誓言》(以下简称《誓言》)成为西方医学道德的典范,对后世产生了极为深远的影响。《誓言》主要内容包括:第一,阐明为患者谋利益的医学宗旨,“我愿尽余之能力与判断力所及,遵守为病家谋利益之信条”;第二,强调尊师重教,“凡授我艺者,敬之如父母,作为终身同业伴侣,彼有急需,我接济之。视彼儿女,犹我兄弟,如欲受业,当免费并无条件传授之”;第三,强调医师的品行修养,“无论至于何处,遇男或女,贵人及贫贱者,我之唯一目的,为病家谋幸福,并检点吾身,不做各种害人及恶劣行为,尤不做诱奸之事”;第四,强调保守医学秘密,“凡我所见所闻,无论有无业务关系,我认为应守秘密者,我愿保守秘密”。

《誓言》是希波克拉底学派在长期医学实践中总结出来的道德行为准则,是历史上倡导医学道德最早、最系统、最重要的文献之一,对后来医学道德的发展起到了不可磨灭的奠基作用。1948年,世界医学会在《誓言》基础上制定了《日内瓦宣言》,并作为国际医德规范。

2. 古罗马医学伦理思想　古罗马时期著名的医学家及医学伦理思想家盖伦(Galen)继承了希波克拉底的体液学说,发展了机体的解剖结构和器官生理概念,创立了医学和生物学的知识体系。

3. 古印度医学伦理思想　古印度是人类文明的发源地之一,其医学伦理思想是世界东方伦理思想的重要组成部分。成书于公元前600年的医学经典《阿育吠陀经》就包含着不少医学伦理思想。例如,阿育吠陀医学的代表人物阇罗迦(Charaka)反对医学商品化,他曾说:“医师治病既不为己,亦不为任何利欲,纯为谋人类幸福,所以医业高于一切;凡以治病谋利者,有如专注于沙砾,而忽视金子之人。”

4. 古阿拉伯医学伦理思想　阿拉伯医学产生和发展于公元6—13世纪,主要继承了西方古希腊以来的医学,同时吸收了中国、波斯和古印度的医学。古阿拉伯医学伦理思想中有突出建树的代表人物是迈蒙尼提斯(Maimonides),他所著《迈蒙尼提斯祷文》是医德史上重要医学道德文献,强调医师应该以患者为中心,不计较金钱和地位,全心全意地为患者服务,医师应该尊重患者的权利和隐私,不泄露患者的隐私信息。同时,医师还应该尽力挽救患者的生命,即使失败了也要勇于承认错误。

二、古代医学伦理思想特征

古代医学伦理思想强调美德,要求医师应以患者为中心,注重医患关系的和谐。同时,医师应该具备高尚的道德品质,如诚实、守信、慈悲等,承担起医德责任,不以谋取个人利益为目的。古代医学伦理思想特征具有朴素性,关注医患关系。这些特征贯穿于古代不同文化和国家的医学实践和思想,反映了人们对于医学伦理的普遍关注和重视,对于现代医学伦理的研究和实践也有重要的启示作用。

(一) 中国古代医学伦理的优良传统和思想特征

中国古代医学伦理思想在历史发展过程中汲取了中国传统文化的精髓,形成以“医乃仁术”为核心特征的优良传统,具体可以概括为如下几个方面。

1. 仁爱救人,普同一等　“仁”是儒家思想的基本概念,是儒家推崇的最高的道德范畴,基本含义是人与人相互亲爱,即仁者爱人。我国历代医家把“仁爱救人”作为行医的基本准则,以儒家文化为主导,强调医学是“以人为本”“济世活人”的“仁术”。晋代名医杨泉在《物理论·论医》中提出:“夫医者,非仁爱之士不可托也。”唐代名医孙思邈强调,医者应先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,不计得失,无畏艰险,全力救死扶伤。宋代林逋在《省心录·论医》中指出:“无恒德者,不可以作医,人命死生之系。”这些观点无不强调仁爱精神的重要性,只有具备济世救人的仁爱精神才能从事医疗工作。

古代医家从朴素的医学人道主义出发,将“普同一等”当作行医的道德信条,这需要相当大的道德勇气,也是难能可贵的医德品质。

2. 博极医源，精勤不倦　《清代名医医案精华》序文提出："医非学养深者不足以鸣世"。医学的根本任务在于以术济人，良好的医学道德必须以精湛的医术为载体。孙思邈在《备急千金要方·大医精诚》中指出："学者必须博极医源，精勤不倦，不得道听途说，而言医道已了，深自误哉。"《黄帝内经》指出：医者必须"上知天文，下知地理，中知人事"。只有知识广博，将医学理论融会贯通者，才能达到更高的医学境界。

3. 重义轻利，廉洁正直　重义轻利是孟子"性善论"所倡导的一种价值观，是儒家的经典思想之一，要求医者必须具备和保持廉洁正直的品行，不可借医技而贪图名利。孙思邈在《备急千金要方·大医精诚》中指出："医人不得恃己所长，专心经略财物，但作救苦之心"。

4. 小心谨慎，尽职尽责　医界历来就有"临病胜临敌""用药如用兵""用药如用刑"之说。历代医家在医疗实践中都着重强调严谨的工作作风。古代医书《本草类方》中提出："盖人命一死，不可复生，故须如此详谨"。张仲景在《伤寒论》中严厉批评那些不负责任、粗心大意、医疗作风草率的庸医。孙思邈指出，一个好的医师应该"省病诊疾，至意深心。详察形候，纤毫勿失。处判针药，无得参差"，强调医者必须保持严谨细致的作风。在临诊时，应充分考虑疾病的复杂性，谨慎地选择治疗方案和药物。

5. 尊重同道，行为端庄　尊重同道，谦虚谨慎，相互学习，取长补短，自古就是医者的优良传统。孙思邈在《备急千金要方·大医精诚》中指出："不得于性命之上，率尔自逞俊快，邀射名誉。"不可"訾毁诸医，自矜己德"。医者的言行举止关系到其能否获得患者的信任。我国古代医学伦理强调，医者应言谈文雅，仪态端庄，在诊治中尊重乡土风俗和病家，做到举止有度，彬彬有礼。早在《黄帝内经》中就提出，医家不可"谬言为道，更名自功"，要"入国问俗，入家问讳，上堂问礼"。

（二）国外古代医学伦理思想特征

国外古代传统医学伦理思想以古希腊、古罗马、古印度和古阿拉伯的医学伦理思想最有代表性，具有以下思想特征。

1. 突出道德及精神生活的价值　古希腊最杰出的医家希波克拉底非常重视医师的品行和道德水平，他在《希波克拉底誓言》中全面而生动地论述了医师与患者、医师与患者家属、师徒之间应有的准则规范。《誓言》提倡的不伤害原则、为患者利益着想原则、保密原则、尊重同道原则，成为西方医学伦理的价值核心思想。盖伦也强调医师的行为在治疗中的价值，认为适当的治疗行为包括道德上的"善"和医疗上的"有效"。

古印度内科书《阇罗迦集》提出为人类谋幸福的行医目的和一系列医德标准：医师治病既不为己，亦不为任何利欲，纯为谋人类幸福，所以医业高于一切。医师在开始接受行医培养的时候就要学习这些准则。阇罗迦认为，在白天和夜晚，无论你给谁看病，你应全身心地为患者的利益而努力，不应因自己的生活或生命的缘故而舍弃或伤害你的患者。

2. 重视医患关系，主张医患平等　古罗马时期，盖伦对医学中的医患关系十分重视。他认为获得患者的合作和信任是十分重要的，这种合作与信任能通过实践交往以适当方式建立。尽管理解患者、了解疾病是不容易的，但医师只有严密地观察和认真地思考，才能将不确定性减到最小。《迈蒙尼提斯祷文》中也有类似论述，"愿绝名利心，尽力为患者""无分爱与憎，不问富与贫""凡诸疾病者，一视如同仁"。

3. 讲求医疗诚信，反对浮夸、虚荣　盖伦在《最好的医师也是哲学家》一文中提出："作为医师不可能一方面赚钱，一方面从事伟大的艺术——医学。""我研究医学，抛弃了娱乐，不求身外之物。"此外，《迈蒙尼提斯祷文》也提出为了人类生命与健康，医师要时刻有医德之心，不应为贪欲、虚荣、名利所干扰，而忘却为人类谋幸福的崇高目标。

三、古代医学伦理思想的局限性

古代医学伦理思想反映古代医学实践与道德观念的交融，但由于科技水平和医学认知水平所限，

古代医学伦理思想也存在局限性。

（一）中国古代医学伦理思想的局限性

中国古代传统医学伦理思想带有历史和阶级的局限性，主要表现在以下几个方面。

第一，部分内容受封建宗法思想、等级观念及某些封建迷信思想的影响。例如："三纲五常""三从四德"等封建道德观念，使妇女看病受到"男女授受不亲"等封建礼教的限制。

第二，受传统儒家文化"忠""孝""仁""义""礼"等伦理观念影响，尸体解剖被视为不孝、不仁、不义行为而被禁止，阻碍了我国尸体解剖研究的进展，一定程度上制约了医学的发展。

此外，还有一些受封建宗法等级观念影响的表现，比如基于宗教的因果报应、天道承负的疾病观等。

（二）国外古代医学伦理思想的局限性

一是有时将当时无法解释的现象简单归因于神灵的力量。如古罗马时期，盖伦医学体系认为，造物主创造的每个结构都是为了满足一定的功能需要，通过解剖学研究可以发现和证实造物主的智慧、力量和完美。

二是一度将宗教教义直接灌输到医学伦理思想中。如古代印度的医学伦理思想就有明显的宗教伦理成分。古印度的医学甚至被称为"佛教医学"。人们认为"佛"是世界的最高主宰，关系人类生存与发展的医学也是佛赐予人的最大恩惠。

第二节 | 近代医学伦理思想

随着近代医学的快速发展，医学伦理问题逐渐成为人们关注的焦点。近代医学伦理思想强调，医师应以患者为中心，注重医疗过程中的道德、法律、人权等方面的问题。同时，新技术带来的医学伦理问题日益凸显，也反映出社会对于医学道德和伦理规范的需求和呼唤。在这样的背景下，近代医学伦理思想逐渐形成并走向成熟，为医学实践和医学教育提供了重要的参考和借鉴。

一、近代医学伦理思想概况

近代医学伦理思想是在科技与医疗制度不断发展的背景下逐步形成的，旨在规范医疗实践、保障患者权益。在近代医学伦理思想的指导下，医疗实践和医学研究逐渐向着更加公正、科学、人性化的方向发展。

（一）中国近代医学伦理思想概况

1840年鸦片战争后，在"西学东渐"大环境下，西方近代医学作为一种新的医学知识体系传入中国，给中国传统医学体系带来空前的冲击。中国近代医学领域出现中西医融合、中西医汇通、改良中医、废止中医和中医科学化等医学西化思潮。中医的生存和发展空间一步步被挤占，逐渐失去其原有的主体地位，甚至关乎存废。到民国初期，西医取代中医的地位成为我国医学的主体。民国时期，随着西方医学在我国的传播和发展，在如何对待中西医学问题上产生了三种态度和主张：全盘西化、完全尊古和中西汇通。中西汇通的主张最为大多数人接受，中国古代医学伦理思想也因此得到了延续、传承和发展。最终，我国逐步形成了中医、西医、中西医结合并存，共同造福人类健康的新局面，中国近代医德思想也步入新阶段。1932年6月，我国知名医学教育家和医学伦理学奠基人宋国宾撰写出版了第一部医学伦理学专著《医业伦理学》。同时，一些国际医务工作者来到中国，也带来了国外的医学伦理思想，促进了中国医学伦理思想和国外医学伦理思想的融合和发展。

新民主主义革命时期，在马克思主义及其中国化理论的指导下，在中国共产党的领导下，我国医务工作者继承我国古代医家优良道德传统，发扬救死扶伤的革命人道主义精神，建立了革命性的同志式医患关系，使中国医学道德步入一个新的历史阶段，中国医学伦理思想发生了革命性的新变化。

1941年，毛泽东同志为当时在延安办学的中国医科大学题词“救死扶伤，实行革命的人道主义”，是对这个时期医学道德思想的集中概括。在这些思想指导下，医务人员和患者共同参与到医疗活动中，建立了平等的同志式新型医患关系。当时，红军医院的制度不仅使人与人之间形成了互相关心、互相爱护、互相帮助的关系，而且使广大医务人员精神上得到解放，世界观、人生观和价值观发生了变化。这也为深入开展医护道德教育营造了有利的环境。

抗日战争时期，很多国际友人投入中国的医疗救护工作，如白求恩、马海德、罗生特、傅莱等，他们的事迹闪耀着革命人道主义和国际主义精神的光辉，他们的医德也是这一时期中国医学伦理思想的重要组成部分。加拿大国际主义战士诺尔曼·白求恩（Norman Bethune）1938年辗转来到延安开展医疗救治工作。1939年，毛泽东在《纪念白求恩》一文中，号召学习“毫不利己，专门利人”“对工作的极端的负责任”“对同志对人民的极端的热忱”的白求恩精神。

（二）国外近代医学伦理思想概况

西方近代医学伦理学发端于14—16世纪的文艺复兴。欧洲中世纪，基督教和经院哲学思想渗透到医学领域，医学的发展被引向引证、注释权威著作的道路，变成了经院医学，医学伦理思想也同样受到宗教的影响。文艺复兴运动冲破中世纪封建宗教统治的黑暗，代表新兴资产阶级生产力和生产关系的思想家提出人道主义的口号，批判以神道为中心的传统观念，倡导以人文主义为中心的新思想，赞颂人的智慧和才能，提倡人性、个性解放和个性自由，肯定人是现实生活的创造者。文艺复兴运动培育了自由研究的精神，引导人们去观察和研究自然和现实社会，为近代自然科学的产生，特别是为医学摆脱宗教的束缚，创造了良好的思想文化条件。资产阶级人道主义思想唤起了良知、自由、平等、博爱的思想潮流，使它们不断渗透到医学领域，促进了以实验医学为基础的近代医学科学的迅速发展，也促进了近代医学伦理思想的发展。

随着近代实验科学的迅速发展，医学逐渐从传统医学向实验医学转变。近代医学科学的发展推动了医疗卫生事业的社会化，医院等专门的医疗机构陆续出现，医疗活动的形式也从个人行医发展到以集体行医为主，医学道德由对医师个人的规范迈向对集体行医中群体的道德要求，医学道德更加规范化、系统化。

医学伦理学作为一门独立学科诞生于18世纪的英国。1772年，英国学者格里高利（Gregory）出版《关于医师的职责和资格的演讲》，指出过于烦琐的陈规可能导致浮夸和不真诚，对于医师的美德是有害的，医师的仁慈应来自其道德感。在疾病的治疗过程中，医师对患者的理解与医术的作用同样重要。因此，格里高利被认为是近代西方医学伦理学的奠基人，是现代生命伦理学的先驱者。18世纪，德国著名医学家胡弗兰德（Hufeland）发表《医德十二箴》，提出救死扶伤、治病救人等具有人道主义思想的医德要求，《医德十二箴》是对《希波克拉底誓言》的发展，它使医德规范更加条理化。

英国医学家、医学伦理学家帕茨瓦尔（Percival）于1791年为英国曼彻斯特医院起草《医院及医务人员行动守则》，并在此基础上于19世纪初出版了世界上第一部《医学伦理学》（*Medical Ethics*）著作，该书全称是《医学伦理学：或适用于内科医师和外科医师的职业行为的机构准则和箴言》（*Medical Ethics: or, A Code of Institutes and Precepts, Adapted to the Professional Conduct of Physicians and Surgeons*）。该书首次使用“医学伦理学”的概念，认为应由基于古代医德规范重视行医者个人德性、医患关系，转换为强调医师群体执业行为的标准化和医方内部关系的和谐；应将古代医德规范过分强调医师的道德义务与责任转换为法律对医疗活动的调节作用。他认为职业伦理学是“人性的知识”与“广泛的道德责任”之间的综合，医学伦理行为受文雅和正直原则指导。这些观点在19世纪被广泛接受。1847年，新成立的美国医学会（American Medical Association，AMA）制定的伦理准则，其主要内容也是直接引自帕茨瓦尔的《医学伦理学》，从中可见其影响之广泛。1803年，帕茨瓦尔的《医学伦理学》的出版，标志着医学伦理学学科的诞生。随后的几个事件，如1863年在日内瓦成立红十字国际委员会、1864年订立《万国红十字会公约》等，使医学伦理学科走向成熟，趋向系统化、规范化、理论化。

二、近代医学伦理思想特征

近代科学进步推动了医学发展，同时也更关注人的需求。在理性与人道之间寻求平衡，是近代医学伦理的主要特征。

（一）中国近代医学伦理思想特征

1. 西方伦理思想融入中国医疗行业　中医是中国传统文化的重要组成部分，在中国古代医疗卫生模式中占据主导地位，形成从理论到临床的独特格局。近代以来，因西医的传入彻底打破了这种格局，对其构成多方面的挑战，中国社会医疗卫生结构也因此而发生本质改变。在与西医的论争中，中医也开始从个体行医模式转变，不断加快行业化建制和社会化进程，改变“一对多”医患关系形态，形成与临床西医学“多对多”和“多对一”同样的形态。

2. 救国救民，关注国家存亡　中国近代医学伦理学思想是伴随着反帝、反封建的革命斗争形成与发展的，是以民族主义、爱国主义和人道主义为特征，孕育形成民族主义和人道主义相结合的旧民主主义医德，更孕育了革命人道主义的新民主主义医德。近代医学伦理思想表现出救国救民的特点，许多具有爱国情怀和民族主义思想的医师，例如孙中山、鲁迅，开始探索救国救民的道路，从关注医学临床伦理转变为关注救亡图存，从医人转为医国，从重医德进而转为重政德。

3. 诞生了革命人道主义精神　新民主主义革命时期，在中国共产党的领导下，以马克思主义世界观和历史观为基础，继承中外历史上优良的医德传统，把爱国主义和国际主义结合起来，大力倡导救死扶伤的革命人道主义精神，建立同志式的新型医患关系，我国医学道德跨入了一个新的历史阶段。坚持“救死扶伤，实行革命的人道主义”，坚持全心全意“为人民服务”，坚持“预防为主、防治结合”等重要指导原则的提出，形成了我军医德原则的基本框架，也成为我军我党领导的抗日根据地的整个医疗卫生工作的医德指导思想。这是一种不同于以往的医学道德，是社会主义医学道德的雏形。

（二）国外近代医学伦理思想特征

1. 崇尚科学理性，形成医德的理论体系　近代医学是摆脱宗教和封建约束，将科学方法和理性分析引入医学，建立在科学基础上的生物医学模式。但在强调科学理性的同时，近代医学伦理也开始重视医患关系在医疗中的重要性。传统医德往往只是零散体现在医家的言行及著述中，大都只是对医德某一方面的规范要求而不成体系，近代医德是建立在对医疗实践活动和对古代医德总结的基础上，用医德法典、规范的形式固定下来，形成较为完整的理论体系。

2. 强调健康权利和人道主义　医学人道主义影响的扩大，从尊重人的生命权利出发，以人道反对神道，冲破了封建神学的束缚。近代医学伦理不仅强调治疗责任，也提出人人享有获得医疗和保健的基本权利。人道主义的理想被引入医学实践，形成医学人道主义思想。

3. 关注社会责任，注重医医关系　医学成为一种社会化的事业，医师与医院之间、医师与医师之间、医师与患者之间建立多层次关系，促使医院管理和医学道德内容扩展和深化，许多国家性、国际性的成文的医学道德守则陆续出现。近代医学伦理不再将道德责任仅限于个体医患关系，而把它扩展到整个社会层面，重视医师和医疗系统对公共健康的社会责任；并开始关注预防医学道德责任，开始重视采取预防措施改善公共卫生环境，预防疾病，而不仅仅是治疗患者。

三、近代医学伦理思想的局限性

近代医学伦理思想为医学实践与医学伦理的发展提供了指导和借鉴。但也存在一些局限性，这里主要尝试论述国外近代医学伦理思想的局限性。

1. 拜金主义思潮兴起，冲击传统医德　近代资本主义社会发展引发的一系列思想变革产生了一些不道德的社会行为。例如，法国神学家弗里兹对当时社会上的不道德行为予以严厉谴责，他在1684年出版的《论王子、大臣、律师、会计、医师和商人等的各种罪行》一书中，列举了医师的23项过错，如未学医而行医、使用未经检验的药物、为获利而拖延治疗、受金钱诱惑毒死患者等。

2. 医学模式机械化，医学人道主义淡化　近代医学伦理强调制定专业规范，提高医疗效率，建立标准化的操作流程，形成机械化的医学模式。但近代以来，由于不完善的城市卫生设施致使瘟疫几次在城市大流行，疫情下医学人道主义淡化，庸医在多地涌现。在近代欧洲，瘟疫暴发严重期间许多城市医师在束手无策又害怕的情况下逃到乡下。

3. 文艺复兴的抽象人性论的影响　文艺复兴以后，人道主义唤醒了良知，自由、平等、博爱的思想渗透到医学的各个领域，人类伦理思想包括医学伦理思想发展到一个重要时期。一方面突出表现为医学人道主义影响的扩大，从尊重人的生命权利出发，冲破了封建神学的束缚；但是另一方面，过于抽象的人性论试图避开人的社会性和阶级性、离开人的社会发展，抽象地解释人的共同本质。受其影响，近代医学伦理侧重强调理性、自主、个体权利等普遍原则，谋划建立一套抽象的共性伦理规范。但这种抽象人性理论忽视了不同文化背景和社会阶层的区别，将特权阶层的价值观当成普世人性，忽视脆弱群体的需要。

第三节 | 现代医学伦理思想

现代医学伦理思想倡导以患者为中心的医疗实践，重视患者的人格尊严和自主权，强调医师和患者之间的互动与合作。同时，也要求医师在治疗过程中遵循科学、公正、透明的原则，保护患者的知情同意权、隐私权和个人信息安全。现代医学伦理思想在维护医疗公正、提高医疗质量和保障患者权益等方面发挥了重要作用。

一、现代医学伦理思想概况

随着现代医学科学和生物技术的迅猛发展和广泛应用，一系列复杂的伦理问题出现，以人道论和义务论作为理论基础的传统医学伦理学已很难应对新局面，在这种背景下，生命伦理学应运而生。生命伦理学是运用伦理学的理论和方法，对生命科学、生物技术及医疗保健等方面的伦理问题进行系统研究，主要以功利论、人权论及公益论等作为理论基础，是对传统医学伦理学的继承和发展。

（一）我国的现代医学伦理思想概况

中华人民共和国成立以来，在大力弘扬优秀传统医德的基础上，大力倡导集体主义道德价值观，在全社会逐步树立和确立了社会主义医德观，为中国现代医学伦理思想奠定了基础。中国现代医学伦理学的形成经历了三个发展阶段。

1. 第一阶段（1949—1978 年）　1949 年中国人民政治协商会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》第四十八条，把“提倡国民体育，推广医药卫生事业，并注意保护母亲、婴儿和儿童的健康”列为建国初期纲领的重要内容。1950 年召开的第一届全国卫生会议把“面向工农兵”“预防为主”“团结中西医”作为卫生工作的三大基本方针。1952 年中央人民政府政务院通过决议，成立“中央防疫委员会”，1953 年改名“中央爱国卫生运动委员会”，正式提出卫生工作的四大方针：面向工农兵，预防为主，团结中西医，卫生工作与群众运动相结合。1954 年第一部《中华人民共和国宪法》（以下简称《宪法》）明确规定保护人民群众的健康权利，确立劳动者有享受休息、休养、治疗和福利设施的权利。1965 年，毛泽东进一步提出“把医疗卫生工作重点放到农村去”的号召，农村卫生工作队伍迅速壮大，这支遍布城乡工厂企业、覆盖偏远乡村的群众性卫生队伍，活跃在基层，有力地保障和维护了最广大人民的身体健康。这一时期，卫生政策伦理思想得到广泛传播。公平、公正、公益的卫生政策伦理基本思想在当时得到了具体体现。

2. 第二阶段（1979—1999 年）　党的十一届三中全会以后，党和政府十分重视社会主义精神文明建设，在医疗领域加强医学道德理论、医学道德规范建设，强调医学道德实践研究，积极开展与国外同行的学术交流。中国医学道德的研究向科学化、系统化、理论化发展，医学伦理学逐渐成为一门较为完整的学科。

1981年，第一次全国医学伦理道德学术讨论会在上海召开，会议提出我国的医德原则是：全心全意为人民服务，救死扶伤，防病治病，实行革命的人道主义。同年，卫生部、各高等医学院校、各省（自治区、直辖市）科协开始加强医学伦理的宣传教育，全国高等医学院校普遍开设了医学伦理学（医德学）课程。1987年，邱仁宗编著的《生命伦理学》出版，该书首次全面系统地向国人介绍生命伦理学，使中国现代医学伦理学研究步入新阶段。

1988年，卫生部颁布《医务人员医德规范及实施办法》，明确医疗卫生服务的道德要求和标准，内容可概括为：救死扶伤，人道待人；尊重患者，一视同仁；文明礼貌，关心体贴；谨言慎行，保守医密；互学互尊，奋发进取；廉洁奉公，遵纪守法。同年，我国第一本医学伦理学研究专刊《中国医学伦理学》杂志在西安医科大学创刊，随后许多省市也成立了医学伦理学学术组织。

1992年，党的十四大决定中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。与此同时，进行了医疗卫生体制改革，新的形势意味着需要探讨市场经济条件下的医学伦理道德建设问题。

1999年，为了保障医师的合法权益，提高医师的职业素养和职业道德，《中华人民共和国执业医师法》正式实施。

3. 第三阶段（2000年至今） 2005年，中国医师协会加入推行《新世纪的医师职业精神——医师宣言》，并于2011年发布了《中国医师宣言》，郑重承诺六条医学守则：平等仁爱、患者至上、真诚守信、精进审慎、廉洁公正、终生学习。这些医学伦理规范的制定，旨在提高医务人员道德水平，推动医学伦理学的发展。医疗保健、卫生政策制定、医学研究、生命科学、环境保护、动物保护等领域都需要伦理考量，尤其是随着高新医学技术的发展和应用，价值论、公益论、人道论、义务论的冲突融合，人工辅助生殖、器官移植、行为控制及卫生资源的合理分配等人类普遍关注的敏感伦理问题层出不穷，医学伦理学逐渐发展到生命伦理学的新阶段。

2016年8月，全国卫生与健康大会召开，同年10月中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，对推进健康中国建设作出了系统部署。习近平总书记指出，没有全民健康就没有全面小康，要把人民健康放在优先发展战略地位，坚持中国特色卫生与健康发展道路，努力全方位全周期保障人民健康。长期以来，我国制定了正确的卫生与健康工作方针，以保障人民健康为中心，以“促健康、转模式、强基层、重保障”为着力点，注重预防为主和健康促进，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。我国卫生与健康事业取得长足发展，显著提高了人民群众健康水平，居民主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平。

（二）国外的现代医学伦理思想概况

20世纪中期以来，生物医学技术发展十分迅速，不仅开启了医学临床实践的新阶段，还带来复杂的伦理问题。例如，克隆人、胚胎干细胞、人工授精、器官移植、基因医学、人类基因组计划、变性手术、严重遗传性疾病、严重缺陷新生儿处置、安乐死及卫生资源分配等领域的伦理问题，引发了人们对新的科学技术是否会被滥用问题的伦理关注与担忧。生命伦理学开始兴起。

生命支持疗法的发展应用，提升了人类对抗病痛和死亡的生存能力，同时也使人类获得更大的自由去维持和控制生命的终结。通过医学技术的进步，人们可以推迟死亡、避免痛苦和减轻残疾，但高新技术在延续人的生命的同时，也导致大量患者的生命质量极其低下，这引发了关于“死亡标准”和“死亡权利”的讨论。

生物医学技术的研发特别是临床医学人体试验引发受试者权益如何保护等伦理问题，冲击着人们的传统道德观。20世纪50年代，美国成立国立卫生研究院支持临床科研，参加临床试验的患者和健康受试者数量急剧增多，各类侵害受试者权益的人体试验时有发生。20世纪70年代，美国“患者权利运动”成为民事权利诉求的一部分，最终促成美国医院联合会通过《患者权利法案》，尊重患者的“医疗、护理、康复、转院、知情、同意、资料、保密、试验、查账”等权利。

生命伦理学的兴起还与特定的社会、经济、文化背景息息相关。20世纪60—70年代是美国历史上重要的文化和社会变革时期，以人权为核心的各种社会文化运动和伦理思潮风起云涌，公民权利运

动兴起。在这样的社会文化背景下，人们开始对现有的伦理命题进行研究和分析，生命伦理学获得了发展的内在动力。随着社会经济的发展，人们对卫生保健的需求越来越高，不仅要求拥有良好的身体素质，还要有良好的心理状态、社会活动能力和较高的生活质量。越来越多的人开始反思和审视自己的生存状态，把医学作为人的文化哲学看待并加以研究成为社会发展的必然趋势。与此同时，医学模式由生物医学模式转向生物-心理-社会医学模式，更加强调关心患者、关注社会、注重技术与服务的共同提高，人类保护健康和防治疾病成为社会性活动。

1971 年美国学者波特在其著作《生命伦理学：通向未来的桥梁》中，首先使用“生命伦理学”一词。在日本、美国和欧洲等国家和地区，生命伦理学已成为医学院校和生命科学院系的必修课程，并设立了博士硕士学位点和专门的研究机构，成立了国家级的生命伦理委员会，医疗卫生机构、医学科研机构、医学院校等设立机构伦理委员会，一些国际性生命伦理学研究机构也相继成立。为了统一规范生命伦理学方面的共识，国际组织先后召开多次会议，拟定宣言和公约。生命伦理学作为一门新兴交叉学科，正逐步发展成为具有重要理论意义和社会现实意义的全球性学科。

二、现代医学伦理思想特征

随着医学科技进步和医疗制度的不断完善，现代医学伦理思想对医师和患者的权利、义务和责任进行了全方位的规范和倡导，涉及医疗实践、医学研究、医学伦理教育、医疗法律等多个方面。这些特征反映了现代医学伦理思想的多样性和发展趋势，为医学实践与医学伦理的进一步发展提供重要借鉴和指导。

（一）医学科研和技术应用带来新的伦理问题

20 世纪以来，自然科学和社会科学发展突飞猛进，伴随医学科技发展出现的社会伦理问题，引起社会各界的重视。第二次世界大战以来，社会各界开始意识到仅靠伦理道德的教化不足以实现伦理学的主张，伦理道德必须得到法律法规的保障，因此诞生了《纽伦堡法典》《赫尔辛基宣言》等，世界各国也通过出台一系列医学伦理法律法规，有效解决了医学发展衍生出来的诸多医学伦理难题。

（二）生命医学伦理学的概念

《生命医学伦理学原则》一书首次提出生命医学伦理学的概念，认为“生命医学伦理学作为一门应用伦理学，是一般道德理论、原则、规范在医疗实践与卫生保健实施以及医学和生命科学中的应用”。随着现代医学的发展和医疗技术、手段、设备的更新，在与人的生命活动各阶段密切相关的医疗实践中，伦理、社会、法律等问题层出不穷。例如，“试管胚胎”养育的婴儿长大后寻找生父的权利问题；由其他人工生殖技术诞生的后代是否享有各种相关权利的问题；人体器官、精子、卵子等的出售与商业化倾向问题；器官移植受者的身份认定问题；寻求胎儿优生、流产与胎儿性别鉴定问题；脑死亡条例的制定及实施问题；安乐死与安宁疗护问题；基因技术与基因歧视、克隆人问题等，单纯依靠美德已经无法约束医疗技术的发展和应用，世界各国开始制定相应的医学伦理规范准则，以期应对可能产生的伦理风险和问题。

（三）新的医学伦理思想和理论

生物医学技术发展本身及其所带来的伦理观念的变化，焦点集中在生死两端，如生殖技术、生育控制、严重缺陷新生儿处置和脑死亡、安乐死等伦理问题，这些争论不休的问题有待进一步深入探索与研究。

在传统医学伦理中，医德的核心思想是义务论，强调把患者的利益放在第一位，专注于个体患者的生命价值，往往忽视了社会价值、社会责任和社会后果。生物医学伦理学的基本原则体现了新的伦理思想，如公益公正论、权利论、生命质量论、生命价值论等。新的思想理论更加综合考虑个人与社会的关系，医务人员不仅要对患者负责，还要对社会负责。此外，医德的发展和实践是涉及人们普遍利益的系统工程。如科学技术发展带来的医疗费用高涨，谁应该成为新药或新技术的受试者，是否应该大力发展人工智能技术等，都需要重新审视，才能促进医疗卫生事业持续、稳定、协调发展。

三、现代医学伦理思想的争鸣与发展趋势

现代医学伦理思想的发展极大地提高了公众及医学专业对医学伦理问题的敏感性，推动现代医学伦理思想向前发展，同时也伴随着许多新挑战和争议，包括以下几个方面。

首先，医患关系的市场化和商业化，导致了医患关系的变质。个别医师为了追逐经济利益，忽视了传统的医德观念。患者也常有“我付钱了，医师就必须满足我所有的要求”的心态。这对医患关系造成了伤害，带来商业化与医疗人文精神之间的矛盾。

其次，医学技术的进步反而加大医学伦理决策难度。比如基因编辑技术的出现，能否进行人类胚胎基因编辑？这关乎人类进化的方向。还有各种人工智能技术在医疗中的应用，如何确保算法公平公正？大数据时代如何保护隐私？现行医学伦理体系如何与新技术相适应？这些都是亟待讨论的新问题。

再次，当前医学伦理教育不够系统，不够深入和全面。医学伦理教育应该贯穿医学院校的整个教学体系，而不是仅仅停留在几节孤立的医学伦理课上，需要建立系统的医学伦理教育与职业前和职业后培训机制。

最后，“尊重生命”与“尊重选择权”之间的价值冲突，医疗资源配置效率与公平性的平衡，不同文化间医疗伦理规范的碰撞，医疗伦理规范与具体实践之间的鸿沟，医学伦理监管体系建设仍不完善，医疗伦理思想亟须与时俱进发展等问题都有待进一步梳理。

现代医学伦理学思想的争鸣，本质上就是由医学伦理学思想分化而形成的各类相关伦理思想在医疗卫生领域的应用，以及学界对不同细化思想进行研究时，碰撞与再融合的思辨过程。

思考题

1. 现代医学伦理学形成的基础是什么？
2. 如何理解社会主义医德是在传统医德基础上发展起来的？
3. 医学伦理学的基本特征是什么？

（陈　旻）

第三章 医学伦理学的理论基础


本章数字资源

医学伦理学作为一门学科，在认识与解决具体的医学伦理问题的实践中，自身学理逐步形成、不断完善并走向成熟。医学伦理学所具有的实践价值，在于通过确定医学领域的道德原则和行为规范，约束和引导医学职业主体恪守原则、遵循规范，践行医学职业精神。原则的确立和规范的形成，虽然源自实践过程中对伦理公理的发现、探索、总结和概括，但是这个过程需要学理分析的参与才可能完成。这一过程是理论与实践相结合的过程，也是逻辑与历史相统一的过程。哲学、道德哲学等人类思想史上的优秀成果，都是医学伦理学的观念、思想、理论和认识的来源。医学伦理学将理论运用于对现实医学伦理问题的认识和解释，在批判和继承中发展与创新着伦理学理论，并同时建构起医学伦理学自身的理论基础。

第一节 | 生命伦理观

生命观（view of life）是对人的生命的根本观点和态度，是将生命作为认识对象并形成系统的观念，又被称为关于生命的哲学观。这种观念无形地统摄和支配人对待生命的态度、情感、意志和行为选择。当这种观念引领人去尊重和热爱生命，说明这种观念本质上是道德的、“善”的生命观，在这样的意义上，生命观转化为伦理层面的道德哲学观念。但是生命是一个复杂的系统构成，如何认识生命和看待生命，一方面要看认识主体站在什么样的哲学立场上、基于什么目的看待和认识生命；另一方面要看生命是以何种结构、形态、性质等与人类认识构成对象性关系。人类的伦理思想史是一部在对生命本质的认识和揭示中反思人与人、人与社会关系的历史。生命神圣论、生命质量论和生命价值论这三种不同的人类生命观，也体现了生命伦理观的不同发展阶段，且相互联系、共同发展。

一、生命神圣论

生命神圣论（theory of sanctity of life）认为人的生命是神圣的，是极其宝贵的，旨在引导人们在道德上关爱人的生命、尊重人的生命、维护人的生命，提倡患者的生命利益和健康利益高于一切。纵观人类道德的发展史，生命神圣论是传统医学道德乃至社会一般道德的基础。“医者，生人之术也”，“医道，古称仙道也，原为活人”，医学自诞生伊始就以救人活命作为根本任务。在医学所走过的历程中，生命神圣论的伦理观在指导医务人员的医学道德实践中曾经发挥了巨大的作用。它一方面驱使着医务人员的医疗行为向着有利于增进和维护人的生命和健康的道德方向发展；另一方面，又保证了医学科学沿着人道主义的轨迹健康发展。为人道行医、为患者谋利益仍是现代医务人员奉行的根本道德信条。

传统医疗条件下的生命神圣伦理观，在医疗服务仅局限于个体治疗、医学道德的考察仅限于医患关系的背景下，它得到了最大限度的奉行和应用。但是，生命神圣论单纯强调“生命至上”和“生命存在”的绝对价值，决定了其思维方式的内在缺陷，即在看到“生命存在”绝对意义的同时，没有认识到“生命存在”的相对性和有条件性。生命神圣论作为一种生命的哲学观念是值得肯定的，只是应该看到，尽管可以认为每一个生命都是神圣的，但是个体生命的有限性和生命存在的境遇不同，生命神圣会呈现出相对性，再神圣的生命也会因疾病、衰老而丧失质量，尤其是在生命支持技术高度发展的

条件下，我们不得不重新审视生命的神圣性。例如，在临床诊疗工作中，对于诸如有严重先天性缺陷几乎没有生命质量可言的新生儿、濒死状态的绝症患者等，按照生命神圣论的观念，医务人员应当选择不惜一切代价进行救治，才可能被认为是道德的，哪怕是在患者以及患者家属强烈要求下的放弃治疗和放弃抢救都会被认为是对生命的不尊重，从而亵渎了生命的神圣性。然而在当下很多的医疗现实中，临终阶段的生命支持技术只是在非理性延长着患者的生物学生命，患者被动承受巨大的痛苦和折磨，同时“不惜一切代价”的生命支持也在“无意义”耗费卫生资源，增加了家庭和社会的额外负担。传统生命神圣论作为唯一的生命伦理观面临着不容忽视的挑战。

二、生命质量论

生命质量论（theory of quality of life）在认同生命神圣的基础上，将注意力集中在对生命质量的考察，主张医学不仅要保全人的性命，更要努力提高人的生存质量。生命质量，就是生命自然素质（包括体力和智力）的状况，通常用“健康程度、治愈希望、预期寿命、智力状况”等来体现。生命质量论是自遗传学和优生学等学科兴起而出现的以人的自然素质的高低、优劣（如器官功能、全身状态等）为依据，衡量应该如何对待生命的一种伦理观念。它强调不仅应该重视生命存在本身，更应该重视生命的质量，人们不应单纯追求生命的数量，更应关注生命的质量，增强和发挥人的潜能。人不仅要活着，更重要的是要活得幸福、美满。

生命质量论的一个基本道德信条是：尊重人的生命，接受人的死亡。这里，“尊重人的生命”强调的是尊重有质量的人的生命；同时，“接受人的死亡”是尊重人的生命的基本内容。

生命质量论的产生，标志着人类生命观发生历史性转变，是人类历史上自我认识和自我控制的发展。生命质量论的形成和发展为人们认识和处理生命问题提供了重要的理论依据，对长期以来困扰人们的生与死的权利及生与死的选择问题，提供了新的参考标准。

但同时，生命质量论也具有自身的局限性。在理论上，生命质量论更侧重从人的自然素质来看待生命，对于生命整体的认识不足；在实践中，由于生命质量高低的判断标准难以达成共识，存在缺乏操作性、实用性的问题。

三、生命价值论

生命价值论（theory of value of life）是在敬畏生命神圣与重视生命质量的基础上，专注人的生命满足人的需要的效用性，认为人的生命价值即对待生命的尺度，以及对其进行相应的动态评价的生命伦理观。该观点伴随着近代各种价值理论的兴起和影响应运而生。生命价值论是生命神圣与生命质量相统一的新的生命伦理观。生命价值论是当代医学道德的主导思想，并作为当代医学实践中对人的生命干预的主要依据。

人的生命是一个渐进、持久并逐渐衰亡的过程，生命价值融于这一过程之中。生命价值包括两个方面：一是生命所具有的满足这个人自身的效用，即生命的内在价值（自我价值），它是由生命质量来决定的；二是生命具有的满足这个人之外的社会和他人的效用，即外在价值（社会价值）。生命的内在价值与外在价值的统一，构成了一个人的生命价值。用生命价值观去指导我们的医疗实践，要求我们既要看到人的生命的内在价值，也要看到生命的外在价值，既要重视生物学生命的存在，又要重视人格生命的社会意义，这是生命价值论的核心所在。

生命价值论为全面认识人的生命的意义提供了依据，同时为解决临床难题提供了理论依据。生命价值论是在生命神圣论和生命质量论的基础上对生命伦理意义的进一步探索。但是，由于人类社会的复杂性和人的社会价值的多样性，在实际的医疗活动中，在选择治疗对象时，如果过多强调生物学的意义以及对社会的贡献大小，可能会造成漠视生命的现象。所以，在以生命价值论主导生命伦理观的同时，应当坚持将多种生命伦理观的精华辩证综合，形成生命神圣、生命质量与生命价值相统一的生命伦理观。

第二节 | 死亡伦理观

死亡观（view of death）是人们对于死亡的根本观点和态度。死亡被认为代表着生命的终结，在走向死亡的历程中，无论人们是否情愿，都将面对死亡以及死亡带来的伦理问题。死亡不是单纯的生物学问题，死亡界限更不是单纯的技术问题。科学认识死亡本质，思考死亡价值，正确对待死亡，领悟死亡真谛从中感悟生命的价值与意义，进而形成死亡伦理观，如此的死亡伦理观便将生命观转化为伦理层面的道德哲学观念。死亡伦理观是关于死亡本质、死亡意义以及如何对待死亡的伦理观点。

一、中西方死亡文化

在中国文化史上，儒家推崇积极入世的理性主义死亡观，主张“生则重生，死则安死”“乐天知命，故不忧”；道家信奉超然物外的自然主义死亡观，主张“生死齐一，死而不亡”；墨家推崇实用的经验主义死亡观，主张“生则见爱，死则见哀”；法家提倡务实主义的死亡观，主张“定理有存亡”；佛家宣扬逃避现实的出世主义死亡观，主张“轮回六趣，具受生死”。

其中，影响最大的是儒家的死亡观。在儒家看来，人们不应过多地考虑“死”本身及死后的事，在儒家文化里没有宗教那种对死后世界追根究底的精神，也没有西方思想及文化中那种冥思死亡、赞美死亡的思维方式。

儒家的死亡观，一方面体现在以什么样的态度对待死亡，另一方面体现在如何“生”的问题，而后者是儒家死亡观的重点。在儒家看来，人生最重要的是专注于现实的感受。既要积极入世，鼓励人们形成积极入世的人生观；又要重生与乐生，重视在世生活，要探索人如何活着、如何活得更有意义，希望人们务本求实，积极努力地追求人生价值。

西方从古到今，在对待死亡问题上更多是关注死后的世界。毕达哥拉斯（Pythagoras）首次明确提出“灵魂永恒不死”的观点，苏格拉底对“灵魂不死”作了进一步阐述，他认为由于灵魂高贵且永恒不死，人的生命便可以不断地轮回。柏拉图（Plato）通过哲学论证灵魂不像肉体或物质的东西那样可以分解成许多部分，它是绝对单一的，所以，“灵魂是不朽的”。笛卡尔（Descartes）作了进一步的论断：“我们的灵魂在本质上完全独立于身体，因而绝不会与身体同死；我们既然找不到毁灭灵魂的原因，自然会因此断定灵魂是不死的了。”

总之，西方死亡文化认为人的生命是有限的和充满诸多不确定因素的，而死亡归宿是永恒的和确定的。

二、科学的死亡伦理观

科学的死亡观认为生和死是一体两面，既相对立又相统一，尽管有生必有死，但是人类在关注躯体死亡的同时，更加重视精神、思想的终结。活着却没有思想，可谓“活而如亡”；已经死亡却在精神上影响着人们，可谓“死而不朽”。因此人生哲学更看重死与生的互动关系。人因为意识到终有一死，意识到死随时可以降临，所以便要思考人生的意义，追求生命的价值，期望实现对于死亡的超越。也正因为如此，死亡就可以成为生命教育的一个缘由。

死亡的本质是个体生命的终结，是自我意识（self-consciousness）的消失。面对死亡的不可逆性以及医学的有限性，我们应当正视死亡，珍惜生命，持有科学的死亡伦理观：死亡是一个复杂的过程，是人的本质特征的消失；树立自然归宿信念；积极追求人生价值；坦然面对死亡。科学的死亡观需要正确的生命教育，生命教育具有重要的意义。

死亡的伦理价值是在正确认识死亡本质的基础上，更加敬畏生命与珍爱生命，从而更好地追求人生价值。

德国存在主义哲学家海德格尔（Heidegger）认为，只有认真面对死亡，把死亡当作自己本己存在

的可能性，才能把握自己本真存在的方式，以自己本真存在的可能性展开和选择自己的生存方式。中国传统文化虽然有忌讳死亡的一面，但儒家伦理认为："未知生，焉知死"，并且崇尚积极乐观地对待生命过程。"由死观生"，是生命哲学的一种深化、延续和扩展。

个体的生命体验是丰富的，不仅有愉悦、幸福等正性的人生体验，也有重要丧失、重大挫折、苦难、失败甚至死亡的威胁。负性体验并不都是有害的，人类往往在面对过苦难和死亡、体验生活的失意后，才能更好地体会到生命的宝贵和不可逆转，进而更加敬畏生命。奥地利心理学家弗兰克（Frankl）认为："对于人生的绝大多数时光而言，生命是平淡的，这种平淡往往掩盖了生命意义的真实显现。对于一个一帆风顺的人而言，只有当他（她）面临死亡时，才会从内心深处真正领悟生命对自己的意义。所以启迪人的经验或发现生命的意义，常常是在生命受到威胁之时，或者是在经历极不平常的事件之时。"可见，由"死"可以反观出"生"的真正意义所在。海德格尔认为死亡即"向死而在"。他认为，死是此"在"的不可超越不可避免的可能，对本真的死的领会或者说畏死能使人由非本真的"在"通向本真的"在"。死亡概念是海德格尔建立以此"在"的本真的"在"为核心的基本本体论的先决条件，因为"本真的存在之本体论结构，须待把先行到死中去之具体结构找出来了才弄得明白。"所谓找出先行到死中去之具体结构，指的不是从生理、心理或经验上来揭示人的死的结构，而是揭示死的本体论的意义，即只有意识到死亡这一最终极的宿命，才能拥有理解并开启"此生之终极意义"的可能。"向死而生"的意义即：由于面对死亡而珍惜自己的生命，进而活出自己的价值，这时的人才是"本真的"存在者。

由死观生，才能更好地敬畏生命与珍爱生命。敬畏生命观是指人们对生命（一切生命，尤其是人的生命）尊重、关爱、敬仰、维护的系统认识和价值判断，是指人们在处理一切与生命相关联的关系，即人与人、人与社会、人与自然关系的过程中持有的以敬重生命、珍惜生命、关爱生命为价值评判原则的基本立场、观点和方法。死亡的伦理价值就是通过正确认识死亡，让人们敬畏生命，从而爱自己、爱他人、爱生命；促使人们深切省思自己与他人、社会、自然，乃至宇宙的关系，展现人性光辉，更好地追求人生价值，活出生命的意义。

第三节 | 健康伦理观

健康观（view of health）是对人类个体以及群体健康的根本看法和观点。健康伦理观是关于健康问题"应当"或"应该"的学问，是对健康主体责任的伦理规范和道德要求。从个体健康向公共健康的拓展形成了在特定伦理立场上认识和看待健康问题所形成的基本观念或根本观点，与此相伴的道德认知与道德实践则推动健康伦理观的形成。党的二十大报告中对于健康中国战略的相关论述表明，全面推进健康中国建设与健康伦理观具有价值统一性。健康伦理观的形成是健康中国战略的重要目标，更是其发展中的价值保障。在全面推进健康中国战略进程中，应当树立正确的健康伦理观。

一、健康与大健康

健康，是人的良好的生命状态，是一个社会共同体内的个体健康与群体健康的统一。西方文化语境中的"public health"一词所表达的内涵正是这样，它既有个体健康的意识，也有公众健康的内涵。

从事物普遍联系的角度认识健康，人是社会中的人，人的健康观是在认识个体健康交互重合的基础上所形成的价值观和规范意识。世界卫生组织将健康定义为身体上、精神上和社会适应上的完好状态，而不仅仅是没有疾病和虚弱。健康是一个人在生理、精神和社会意义上达到完整和平衡的状态，这种状态使人体的功能性能力最大限度地实现。

人类社会工业化、城镇化、人口老龄化，以及疾病谱、生态环境及生活方式的不断变化等，为维护和促进人类健康带来一系列新的挑战。为了积极应对健康风险的威胁，现代医学从个体到群体、从微

观到宏观、从局部到整体的特征不断彰显，医学教育、医学研究、医疗服务不断强化整合理念，以应对日益紧迫的现实挑战，由此，“大健康”“全健康”等理念逐步深入人心。

大健康是在“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”的背景下，注重不同群体、不同个体的健康水平、状态及所处环境与健康关系的总和。2016 年 10 月，中共中央、国务院印发的《“健康中国 2030”规划纲要》确立了“以促进健康为中心”的大健康观和大卫生观。健康中国战略要求树立大卫生、大健康观念，旨在建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合，其中特别强调包含公共健康在内的以预防为主的“全民健康”和“人人健康”理念。面对“服务生命全周期、健康全过程”的变化，医务人员应树立大健康理念，强化全过程健康思维、全人群健康思维、全方位健康思维的培养。

二、健康权利

健康权利是个体作为道德主体享有的与健康相关的道德权利。健康权作为一项人权，在第二次世界大战之后经由国际法的途径得到发展。联合国 1946 年通过的《世界卫生组织组织法》首次提出人的基本权利之一便是“享受最高而能获得的健康标准”；1948 年的《世界人权宣言》为健康权奠定国际法律框架，但表述较为保守。健康权第一次以具有法律约束力的公约形式出现是在 1966 年的《经济、社会及文化权利国际公约》，该公约将健康权表述为“人人所能够达到且享有的最高体质和心理健康”。随后，区域性多边条约也对健康权作出表述，如《欧洲社会宪章》和《美洲人权公约关于经济、社会和文化权利领域的附加议定书》等。受此影响，越来越多的国家将健康权纳入本国宪法规定中。2008 年联合国人权委员会的一项统计表明，至少有 115 个国家的宪法规定了健康权或者健康照顾权，6 部以上的宪法规定了与健康权有关的责任。

在《中华人民共和国宪法》（以下简称《宪法》）中，健康权属于一项隐含权利，第三十三条人权条款和第三十八条人格条款是健康权立法的权利根基和价值指引。从《宪法》的第二十一条、第二十六条、第三十三条、第三十六条和第四十五条等规定可以得出健康权的内容兼具自由权和社会权的属性：“公民健康不受侵犯”，这是国家以消极义务的方式防止公民受到伤害，是自由权的范畴。“国家发展医疗卫生事业，发展现代医药和我国传统医药，鼓励和支持农村集体经济组织、国家企业事业组织和街道组织举办各种医疗卫生设施，开展群众性的卫生活动，保护人民健康”以及“中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业”，这是国家履行义务保障公民健康的权利，是社会权的范畴。从《宪法》规定来看，虽然健康权兼具自由权和社会权属性，但更多是一种靠国家积极履行义务来保障的社会权。我国的民事法律体系将健康权视为一种私法权利，是消极权利，2021 年实施的《中华人民共和国民法典》将健康权作为自然人的一项重要人格权予以规定。《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》（2019 年颁布，2020 年实施）明确提出“国家和社会尊重、保护公民的健康权”，并详细规定了公民与基本医疗服务、药品供应和健康促进有关的健康权益，这是首次将健康权以法律的形式确定下来，推动健康中国战略的实施，而《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》的核心就是明确国家有义务为公民提供基本医疗卫生服务，以此来保障公民健康权得以实现。

健康伦理视野下的健康权利，是“人人享有可能达到最高标准的、维持身体的生理功能正常运转以及心理良好状态的权利”（《世界人权宣言》），它“至少包括通常的、无限制的健康维护权、医疗保障权、基本医疗需求权、医疗保险权及其他内容”。健康权利作为一种人人都应享有的普遍权利，本质特点是主体平等，即不论人们的社会地位如何，每个人都应该享有平等的健康权利；政府应该为每个人健康权利的实现提供平等保障。应该说，世界卫生组织提出的“人人享有健康权”、我国施行的“人人享有卫生保健”政策都充分体现了健康权利的普遍性和平等性。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。全

面推进健康中国建设，就是要通过相应法律制度和政策措施的设计与实施，为公民提供公平可及的健康服务和健康保障，从而为最终实现每一位公民的健康权利在事实上的平等创造条件。

三、健康责任

健康责任是道德主体所应承担的与健康相关的伦理责任。“健康为人人、人人为健康”是形成健康责任的伦理基础。健康责任的道德主体不仅包括健康专业人员，还包括所有相关者——政府、媒体、企业以及公民个人等，前者承担公共健康职业责任，后者与健康专业人员一起承担公共健康共同责任。维护健康是一项社会系统工程，既要靠经济社会的发展和医疗科技的进步，也要靠健康生活习惯的普及和社会环境的改善；既要靠公平正义的法律制度和理性的政策设计，也要靠各健康主体高度的责任意识和道德自律。

健康伦理有赖于健康权利的实现，而健康权利的实现，主要在于各类健康责任的落实，即“健康共建共享”。“共建共享，全民健康”是建设健康中国的战略主题，其核心思想是“以人民健康为中心”。在2016年的全国卫生与健康大会上，习近平总书记明确指出，“健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求”“要坚持正确的卫生与健康工作方针，以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，把健康融入所有政策，人民共建共享”。

“共建共享，全民健康”需要不断扩展健康责任的限度和范围，正如德国思想家约纳斯（Jonas）所言：“道德责任不只包括对属于人类范围之内的事物的责任（如对个人、家庭、社会、国家和全人类的责任），而且已增加了对整个大自然生物圈的责任。”因此，健康责任不仅要求健康主体对自身角色及其行为后果自觉承担相应的责任，而且要求主体有对家庭、社会和自然环境等的高度责任感。对于健康责任的重视与深化研究有利于人类个体的生存和发展，有利于整个人类社会的生存和发展。

“共建共享，全民健康”需要“人人健康，人人参与”。所以，应当尊重和保障每一位公民的健康权利，同时，应当强化每一个公民的健康责任，充分激发每一位公民作为健康建设的参与者、支持者的主动性和创造性，同时进一步完善政府、企业以及相关社会组织的健康责任，这不仅是实现全民健康的题中之义，也是全面推进健康中国建设的内在动力和健康伦理的基本价值目标。

第四节 | 道义论

道义亦称义务。道义指道德与义理，与功利相对。强调道德义务的伦理思想被称作道义论（theory of duty）。道义论又被称为义务论（deontology），或非目的论（non-teleology）等，道义论是指人的行为必须遵照某种道德原则或按照某种正当性去行为的道德理论，与功利主义相对。道义论主张社会确立道德的目的在于道德自身，在于完善每个人的品德；道义论强调人们应当遵循一定的道德义务和原则，以承担起道德责任，而不是基于行为的后果来评判一个行为是否正确。

一、道义论的内涵与特点

（一）道义论的内涵

道义论源自希腊词“deon”，意为“那适当的”“那应当的”或“职责”。中国古代道义观念的源头可以追溯到商末周初。

中国古代的儒家思想认为，尽管人们天生就有求义或欲利或两者兼有的本性，但在处理义利关系时的正确态度应当是重义轻利、先义而后利，甚至尚义反利。一方面，完善每个人的品德是为了实现“人之所以异于禽兽、人之所以为人”。孟子曰：“人之有道也，饱食、暖衣、逸居而无教，则近于禽兽。”另一方面，凡事当前，我们选择行为时，首先必须考虑的是道义要求，一旦道义原则被履行了，则行为主体的个人利益与好处也将随之而来。只有以义为本，才能统一义利，也就是要先义后利。西汉儒学

大师董仲舒将这一思想概括为:“正其义不谋其利,明其道不计其功。”

作为一种完整的理论,道义论是由18世纪德国哲学家康德(Kant)提出来的,他是道义论的典型代表。康德认为,人的道德义务来源于先验的善良意志,是善良意志发出的所谓的“道德律令”,即“头顶上的星空”和“心中的道德律”。所谓善良意志,是指意志本身的善,是在宇宙间唯一不加任何条件的善。它是一切善的根源,善良意志是康德义务论体系的首要命题。他从“善良意志”出发提出“为义务而义务”的主张。因为义务是善良意志的指令,所以义务内在地包含了善良意志,因此康德得出“只有出于义务心而作出的行为才是善的,出于其他偏好而作出的行为,由于不是出于善良意志因而不可能是善的”。康德所强调的这种义务论是主张遵照某种既定的原则或者某种东西本身所固有的正当性去行为,而不去考虑行为对人对己带来的结果如何。其实质在于强调义务的绝对性、至高无上性、命令性和无条件性。

在西方现代伦理学中,人们行为或活动的道德性质和意义,最基本的不在于其所达成的目的(或者其所体现的内在价值),而首先在于它们所具有的伦理正当性。

(二) 道义论的特点

首先,道义论在道德评价中注重行为本身是否符合道德规定,强调行为的动机,而不是以结果为评价善恶的依据,因此也有人将道义论称为动机论,认为只要行为的动机是善的,不论结果如何,这个行为都是道德的。

其次,道义论认为道德规范具有普遍性,甚至是绝对的普遍性。道义论的这种道德普遍主义的规范主张或绝对化的道义诉求,源于它对道德判断的形式化条件的前提性依赖:行为在道德上是否正当合理,不能由其所产生的具体效果来确定,而应当首先看它是否与确定的道德原则或道德规范相符。由于道德原则或道德规范是行为是否符合道义的基本判断和评价标准,因此伦理道义论者往往把制定具有普遍有效性的道德原则(规范)当作伦理学的第一要务,视为建立伦理理论体系的首要之事。

二、道义论在医学实践中的运用

道义论侧重考量道德行为的动机,不注重行为的后果,而诉诸一定的行为规则、规范及标准,其理论的核心是义务和责任。道义论认为,行为的正确与否,并不是由行为的后果来决定的,而是由这个行为的动机和标准来决定的,注重判断行为的动机是否是“善”的,是否体现了预设的道德标准,这样就突出了道义理性的地位,把道义行为的内在本质认定为是预设的和普遍的。

道义论强调履行义务的行为动机,这种观念在医学实践中有着悠久的历史传统。古巴比伦的《汉谟拉比法典》、古希腊的《希波克拉底誓言》、中国传统的医学经典《黄帝内经》《千金要方》等都包含了对医者的道德义务和行医动机的强调。

三、道义论的评价

道义论伦理学是伦理学历史发展中的重要理论流派,作为一种主要的理论流派,道义论的理论内涵十分丰富,其显著的特征是强调道德行为的动机,将义务和责任看成其理论的核心概念,强调道德理性的基础性地位,把道德理性看作道德行为的内在本质。在进行道德评价和道德决策时,道义论主张强调履行“义务”和“责任”,强调“善”的动机,主张人与人之间的平等。这些对于整个人类社会的稳定与发展起到重要的维系作用。传统的医学伦理学是以道义论为轴心的理论体系。围绕道德义务的根本信念而建立起来的对医学主体的各种美德要求与美德规劝,体现道德义务与美德的各种规范与应尽的责任要求等,都是传统医学伦理学的重要内容。在当代生物医学的发展所带来的医学伦理学转型的过程中,道义论在医学伦理学发展中和医德实践中仍发挥着重要的历史作用。

在实践中,道义论也体现出明显的片面性。首先,“善良意志”“道德原则”或“绝对命令”从何而来并没有得到根本性的解答。不同学派会有不同回答,道德的多元性意味着不易形成普世伦理。

其次，由于对道德行为全过程的把握不够全面和彻底，它有可能忽视人的需要、目标和派生价值而走向极端。再次，科学和技术的发展带来的一系列道德难题和医学道德的时代性困境，仅仅以道义论作为理论基础和方法手段同样是十分软弱和无力的。

第五节 | 后果论

后果论（consequentialism），又称效果论、效用主义或功利主义（utilitarianism）、目的论（teleology）或价值论（theory of value）等。后果论是一种把强调行为的功利后果和对他人、对社会的普遍功用作为对人的行为道德价值判断和评价根据的伦理学理论。该理论主张，社会确立道德的目的，在于道德自身，在于完善每个人的品德；行为是否道德，其终极的标准只能看它对行为者的品德、道义的效用如何。

一、后果论的内涵与特点

（一）后果论的内涵

功利主义的“最大多数人的最大幸福”是代表和反映这种伦理思想本质的核心原则。后果论的内涵具体体现在古典功利主义与现代功利主义两种思想体系中。

1. 古典功利主义　17 世纪，英国经验主义哲学家培根（Bacon）、英国哲学家霍布斯（Hobbes）就已经阐述了他们的功利主义伦理思想，进入 18 世纪后，功利主义伦理思想又在英国哲学家洛克（Locke）、荷兰哲学家曼德维尔（Mandeville）以及苏格兰哲学家哈奇森（Hutcheson）、休谟（Hume）和英国经济学家、哲学家斯密（Smith）的哲学、伦理学著作中得到了进一步的运用和发挥。但是，作为一种系统的、完整的伦理学说，古典功利主义还是在 18 世纪末、19 世纪初由英国哲学家边沁（Bentham）和密尔（Mill）完成的。

边沁和密尔是古典功利主义理论的主要代表。边沁和密尔都把快乐主义作为其功利主义的基础，把趋乐避苦作为其论证功利主义原理的根据。按照他们的理解，趋乐避苦是人所共有的自然本性，是伦理道德建立的根据。边沁说：“自然把人类置于两个至上的主人‘苦’与‘乐’的统治之下，只有它们两个才能指出我们应该做些什么，以及决定我们将怎样做。”快乐和痛苦是决定人们行为应该如何的标准，趋乐避苦是人行为的指南，那些能给人带来快乐的，是人应该做的，或值得去做的，而那些会给人带来痛苦的，则是人不应该去做的，或是不值得去做的。快乐和痛苦不仅是人的行为应该如何的标准，还是人的行为善恶的道德判断标准。在边沁、密尔看来，能够给人带来快乐的行为就是善的、道德的，否则就是恶的、不道德的；如果一种行为带来的快乐超过其带来的痛苦，那它就是善的、道德的，一种行为带来的快乐减除其痛苦的余额超过另一行为带来的快乐减除其痛苦的余额，那它就比另一行为更善；而在一切可能的行为中，包含的快乐超过痛苦的盈余最大的行为，就是最大的善。在快乐主义基础上，边沁、密尔都得出了功利主义伦理原则，即最大多数人的最大幸福。如果一种行为带来的快乐的成分占优势，其就是道德的行为；如果一种行为带来的完全是快乐而没有痛苦则是最大的幸福，当最大多数人都争得这种最大幸福，也就达到了最大多数人的最大幸福。

总体而言，古典功利主义伦理思想的基本观点主要包括五个方面。①个体道德理论：这种理论强调对人的理解不应当是从道德哲学反思的角度，而必须建立在对人的实际经验的基础上。“苦乐原理”是这一理论的基石。②社会功用理论：在“苦乐原理”的基础上，功利主义伦理学建立了功用原则和最大幸福的原则，从而将个体道德理论扩展到社会伦理领域。所谓功用原则，是对任何一种行为的评价，要以这种行为增加或减少当事者的幸福为根据。当事者不仅仅是指个人主体，还包括政府部门和社会组织。最大幸福原则是对功用原则的发展，这一原则克服了功用原则中“功用”概念与幸福、快乐等观念联系不够明确的缺陷。③法律调节理论：在古典功利主义思想家看来，法律调节理论是建立在“苦乐原理”基础上的，道德上衡量善恶的幸福和快乐的增加或减少，在政治上就是优越，在法律上就是

权利。④个人的自由权和自我发展：在功利主义幸福概念的内涵中，个人自由权和自我发展是两个重要的内容。任何人的幸福都是与其精神和个性的自由发展相联系的。⑤作为人们内心情感的良心：功利主义认为只有人的良心才能够为功用原则提供其义务性的根本来源，提供其准则性的最终动力。

2. 现代功利主义　行为功利主义和准则功利主义是现代功利主义具有代表性的两大派别。行为功利主义伦理学强调根据具体情况下的具体行为所产生的效果来确证一个行为的正当性，准则功利主义则强调人的行为的道德价值要根据这一行为与某类能够带来好的效果的具有普遍意义的规则相比是否具有一致性来加以确证。

行为功利主义以澳大利亚哲学家斯马特（Smart）为代表。斯马特指出："功利主义是这样一种观点，它认为一种行为的正当性或不当性仅依赖于其结果的总体善性或恶性，即依赖于该行为对所有人类（或许是所有有感觉能力的存在）的福利之影响效果。"斯马特认为行为功利主义把行为之善恶建立在行为之后果上。从总体上看，行为功利主义是对边沁、密尔古典功利主义的"最大多数人的最大幸福"这一功利主义原则的复述与维护。

准则功利主义以美国伦理学家布兰特（Brandt）等人为代表。准则功利主义在坚持效用原则的同时，认为人们行为的正当性与行为的结果没有直接的联系，主张评价人们行为的正当性要看行为是否符合据以实现好的效果的道德规则，而遵守一般的道德规则会使人获得最大的好处。布兰特把社会的道德规则称为"道德法典"，认为道德法典构成了对群体道德行为的限制与调控系统，体现为确定的社会准则。布兰特指出："一种具有多条道德规则并经过合理选择的系统才是可能的，它是最大限度地实现福利，因而是完全有理性的人可能支持的那种道德体系。"这种道德体系是由多种道德规则组成的法典系统，它的目标是"最大限度地实现福利"，它强调的不是功利本身，而是达到功利目的的行为规则系统。布兰特所主张的准则功利主义，对于克服行为功利主义只顾特殊行为、不顾人类行为的一般特征，对于克服只讲效果价值、忽略动机与义务，只注意行为的最终状态而轻视行为过程等功利主义的极端性方面，有着积极意义。

（二）后果论的特点

1. 强调行为的结果，不重视行为的动机。判断某个行为是否善，后果论主张看这个行为是否带来好处，而不论行为者出于什么动机，只要产生更大的快乐和幸福，就是善的，是应该被鼓励和赞赏的。

2. 以个体经验为基础，以经验生活中的苦乐感受为标准。与道义论的超验性不同，功利主义者在行为前会进行利益的权衡，通过计算利弊得失来决定是否采取行为，采取何种行为。

二、后果论在医学实践中的运用

随着医学实践的发展，以功利主义伦理学为代表的后果论，作为基本的伦理理论成为生命伦理学的一种必然诉求。功利主义伦理理论为世人提供了一种基本的道德思考模式，主张从行为后果对人的幸福和快乐的影响程度来判定行为的正当与否。功利主义不是单纯从原则出发，而是主张具体地分析和比较可供选择的不同的行为后果。后果论思路，对个人和社会幸福的注重，对个人利益和社会利益关系的调和以及对道德制裁力的研究，为伦理学的研究和应用提供了理论上的有益启示。事实上，对于促进现代生命伦理学理论的建立和成熟，功利主义伦理学理论扮演了重要的角色。因为无论是生命质量的确定、生命价值的判断、死亡方式的选择，还是有限卫生资源的合理分配、医疗卫生事业的宏观决策等，都存在依据什么样的标准进行价值判断和道德选择的问题，在这种选择中，功利主义伦理学的理论在方法和原则上具有不可替代的理论功用。

三、后果论的评价

后果论在推动社会发展包括医学发展方面起到了重大的作用。

第一，后果论从人的本性而不是从神的目的去说明价值和道德的起源和目的，强调道德是为了人

而不是神、道德是使人幸福，提倡尊重人性、人的尊严、人的价值和人的主体性，进而在思想领域产生巨大的影响。

第二，后果论强调行为的效用是其是否道德的基础，有效地防止了因空谈道德和义务所导致的道德至上论和教条主义。只有明确了道德的目的、道德的价值所在，才能为道德提供最终的标准，才能说明人类行为的正确所在。

第三，后果论把个人对幸福的追求同利他和公益事业结合起来，以克服极端利己主义的片面性，力图兼顾个人利益、集体利益与社会利益，兼顾短期利益和长远利益，这对人类社会的发展具有积极的推动意义。

但是后果论侧重于行为的效果，在理论上也存在缺陷。

首先，如果只是专注于效果而不考虑动机，就势必造成把出于善良愿望，并尽了最大努力，只是因为预料不到的（即责任范围之外的）原因，不能达到应有的效果的行为，看作不道德的行为。动机与效果的统一要求我们对于行为的善恶，必须既看动机，又看效果，联系动机看效果，透过效果看动机。医学后果论强调把医学行为的效用作为制定医学道德规范的依据和判断具体医学行为道德与否的标准。医学后果论同样存在后果论的共性问题：在医疗实践中如何去计算和衡量一个行为可能产生的不同效果？有些后果可以定量，有些难以甚至不能定量。而且医患之间的文化水平和价值认知有时候存在差异，每一后果给予的权重是不同的，因此，不应仅仅考虑后果而不考虑动机。

其次，功利主义的出发点和落脚点最终是利益。虽然功利主义并非利己主义那样主张利己优先，现代功利主义也主张兼顾他人和社会利益，但是，功利主义无法改变以利益（快乐、幸福）确立道德目的的基本立场，就不可能真正从道德要求的角度兼顾好个人利益和社会利益的关系，理所当然，它也就不可能保证最大多数人的最大幸福的功利原则真正实现。因此无论功利主义者怎样谈论最大多数人的最大幸福，只要他们把利益（幸福）建立在个体是否快乐的基础上，这种功利仍然是个体功利，而不是社会功利，容易走向利己主义。

第六节 | 美德论

美德是指在一定的社会历史条件下经过长期的道德实践而逐渐形成的、受到普遍尊崇、具有普遍和永恒价值的优秀道德品质。美德论主要以行为者为中心，研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格、什么是有意义的生活。美德论（theory of virtue），又被称为德性论、德行论。美德论主张，德性概念所标识的是道德主体自身完善的一种人格境界，一个人只要拥有适宜的美德，自然就会作出好的道德判断，即作出合乎伦理的行为决策、评价和辩护。

一、美德论的内涵与特点

（一）美德论的内涵

伦理学认为，德性是指个体所具有的理解、内化与践履伦理原则和道德规范的秉性、气质和能力，中西方传统都崇尚德性。德性既是化“德”为“性”从而达到“从心所欲不逾矩”的境界，又是“一种获得性人类品质”。

中国儒家德性论的核心是建构了一个内容涉及人们生活各个领域的德性系统，同时构成了人们生活的行为准则和修养的理想目标。在这个系统中，以“仁”为核心的“仁、义、礼、智、信”是其中最重要的内容。“仁爱”体现“生”的精神与理念，它不仅是一种慈爱、宽厚与同情，更是促生、利生的具体行动。儒家德性伦理的实践价值是“推己及人、修身养性”，其实践理性原则是“己所不欲，勿施于人”和“中庸”或“中道”。中庸的核心是作为道德规范的“诚”。“诚”在中国传统的道德认识中广泛地作用于自然、社会和思维各个领域，是具有“正人正己”“成己成物”功用的重要道德信条，其理想的人格载体是“君子”，其最高的境界则是“致广大而尽精微，极高明而道中庸”。

由古希腊开始的西方德性伦理也有自身的历史谱系。古希腊数学家、哲学家毕达哥拉斯（Pythagoras）认为“美德乃是一种和谐”，古希腊哲学家苏格拉底（Socrates）的“知识即德性”的命题把真与善、知识理性与价值理性内在地统一起来。在西方，对德性伦理进行系统而深刻分析并为西方德性伦理学奠定系统理论根基的是古希腊哲学家亚里士多德（Aristotle）。首先，他批判了前人的德性观，认同人的本性在于理性，但也看到非理性因素的作用，德性是指灵魂方面的优秀而不是肉体方面的优秀。其次，亚里士多德分析了德性的具体形式和内容。再次，他认为德性生成自实践行为。最后，亚里士多德论述了德性的目的。他明确提出德性的目的在于达到幸福，而善和幸福就是合乎德性的实现活动。

在东西方德性伦理历史谱系的对比分析中，我们可以看到两种不同的基本生存图式和伦理路径：“修身—躬行—生活—成人”为东方儒家德性伦理的自我生存图式；“传统—实践—共同体—幸福生活”为西方美德伦理的基本生存图式。两种生存图式启示我们：伦理学包括医学伦理学或生命伦理学的作用都不仅仅在于成就个体的某种美德，还要认同并参与作为一种生命存在的人的幸福生活的实现活动或促进一种“可能生活”乃至“好生活”，这无疑需要把个体的德性状态与社会结构、制度德性的伦理精神结合起来。对于医学伦理学和生命伦理学来说，不但要塑造具有热爱生命、尊重生命、维护生命尊严的人文情怀与生命精神的医务工作者，而且需要对卫生医疗体制进行伦理设计以优化卫生资源的配置，这是建构医疗卫生秩序的重要制度保障。

医疗卫生领域中的伦理关系是最丰富的人际关系之一，它对人的德性具有更高的要求。医学美德论主要讨论行医者的职业美德，如仁慈、诚挚、严谨、公正和节操等，并在医疗行业中提倡这些美德。

（二）美德论的特点

1. 强调个人行为的稳定性。对于个人美德的评价，并非根据一时一事的行为表现，而是根据个人一贯性、长期性的行为表现。医学实践中也是如此，医务人员只有在医学实践中将具体美德始终如一地坚持下去，才能被称为有美德的医者。

2. 强调个人行为的自律性。美德论强调个人自律和自我控制。医学美德论强调医务人员自觉自愿地保持和提升个人的职业道德修养，全心全意地为患者服务。不论在什么情况下，都要自觉地履行医学道德义务，而这正是医学美德修养所必需的。

二、美德论在医学实践中的运用

美德论以品德、美德和行为者为中心，研究和探讨人应该具有什么样的道德品质，有道德的人是什么样的人，人应该具有什么样的品德或品格。不同的时代、不同的国家、不同的民族对美德的理解和概括有所不同，要求也不同。中国传统德性在医学实践中提倡医者的奉献精神和医德规范，如仁爱救人、清廉正直、医术精湛、不畏艰难、勇于创新、谦虚好学和献身精神等。西方传统德性伦理在西方医学的实践中，始终是行医者恪守的职业信条。从《希波克拉底誓言》开始，就强调医务人员对于医学的奉献精神和牺牲精神，追崇医德的至善境界。18 世纪后期，格里高利在《关于医师的职责和资格的演讲》中指出，同情应当作为医师的首要美德。他认为，医师对于患者有基本的道德责任，这种责任包括仁慈、耐心、关怀、谨慎、保密、道义、公正和同情。美德论及其包含的具体美德要求无疑对医学伦理学的理论和实践产生了重要的影响。

三、医学美德论的评价

医学美德论在医学伦理学的理论体系中具有重要的地位，对医务人员塑造完美人格具有重要的理论指导意义。

首先，医学美德论是医学伦理学理论体系的重要组成部分。美德论是医学伦理学早期的理论基础，历代医学道德都很强调美德，无论是以希波克拉底为代表的西方医德思想，还是以孙思邈为集大成者的我国医德传统，对医者都有较高的美德要求。而在当下的医学伦理实践中，我们所倡导的热爱

医学、忠于医学、献身医学，具有医德节操，救死扶伤、防病治病、全心全意为患者服务，主持正义、廉洁正直等道德要求，依然是医学美德在医务人员职业道德上的基本体现。医学伦理学是关于医学道德的理论体系，医学美德论无疑是医学伦理学理论体系不可或缺的组成部分。

其次，医学美德论有利于医务人员塑造完美人格。医学美德论以医学品德、医学美德和医务人员为中心，研究和探讨医务人员应具有怎样的品德或品格。医学职业自产生以来，正是由于无数的从医者具备“大医精诚”“医乃仁术”，救死扶伤、实行人道主义的医学精神，体现出高尚的医学道德品质，保证了医学的仁学性质和人道的特点。随着时代的变化和发展，医学家和医学伦理学家又不断提出新的美德要求，使医务人员所具备的美德得以不断完善和发展。

当然，随着医学实践的不断发展，医学美德论也不可避免地显现出了局限性。

首先，医学美德论仅从直观层面上、从医学职业本身对医务人员提出了“应该具备什么样的美德”的要求，还未能在某种特定情景下对医务人员应该如何做提供具体建议。医学美德现象的背后还有更深刻的理论基础，需要我们对医学美德背后的医学道德进行进一步的揭示和研究，进一步明确医学道德规范的内容，并使之发挥作用。

其次，当下的医疗行为由个体面向集体和社会，医疗实践不但关涉医治疾病而且已上升为一种社会责任，美德论仅仅停留于主观品性、人格等精神形态的存在方式之中，缺乏制度化，只能有赖于个人的道德修养，不能更有效地提高整体的宏观的行业道德。

再次，当下价值观多元化，每个人对美德的理解或者侧重点不统一，在医患关系的处理中，由于价值观的不同，单独通过美德论指导医务人员的行为往往不能达到预期的效果。

当代医学伦理学的理论基础不可能只采用单一的理论构成，必然是综合了道义论、后果论、美德论以及其他理论形态中的合理成分，积极汲取西方医学伦理学理论中的有益成分，大力继承传统优秀医学伦理思想并进行现代化转型，扬长避短，形成理论上的互补和整合，才能发挥指导医学道德实践的重要作用。

思考题

1. 如何理解生命观与死亡观的关系？
2. 如何从伦理的角度理解健康权利与健康责任？
3. 比较中国的德性论与西方的德性论。
4. 分析道义论、后果论与美德论各自的理论优势和不足。

（郭玉宇）

第四章 医学道德规范



本章数字资源

伴随社会的变迁，医学道德经历了从美德到规范的演进。古代医德学阶段更多凸显医者的德性，现代伦理学阶段更倾向于以规范的形态来表达医学道德。我们要理解作为一种社会实践的医学道德规范，既要明晰道德规范性的意蕴，明确其与其他规范性的联系和区别；还要明晰医学道德为何具有这种规范。其中，医学道德的来源涉及医学道德规范实践这一根本性问题。本章在阐释医学道德规范概念的基础上，介绍国际国内重要的医学道德规范文件及其内容。

第一节 | 医学道德规范的概念及分类

医学道德规范是依据一定的医学道德理论和原则制定的以调整医疗人际关系、评价医疗行为的准则和规则。在传统的个体行医实践中，医学道德规范主要基于医者个人自律而形成。中国历朝历代许多医家在行医过程中，逐渐认识到行医的道德属性和道德要求，并体现在自己的行医实践中，有的医家便在自己的医学著述中加以阐述，当时的医学道德规范往往由名医大家提出。随着医学和医疗实践的发展和进步，医疗卫生实践的社会化程度不断提高，医学道德规范逐渐变为基于医学行业自律而形成。为平衡医疗行为与社会的关系，国际国内各类医学行业组织先后成立，并制定行业道德规范，规范医学行业中的执业行为。例如，世界医学会制定的《国际医学伦理准则》《赫尔辛基宣言》等。

从医务人员视角看，医学道德规范意味着他们在医疗实践中的行为是“非任意性的”，而且是义务性的，这为医疗实践行为提供了“压倒性的理由”。在形式上，早期的医学道德规范更多以“戒律”“宣言”“誓言”“法典”等形式存在。医学伦理的产生，很大程度上推进了医学会等社会组织和政府制定守则、办法或宣言，其中包含了医学道德规范的内容。为更好理解医学道德的规范性，我们需要厘清几组相关性范畴。

一、有义务做某事和强迫做某事

本质上说，规范性概念在形式上表现为具有规范性的内容或命题，而某种具有约束性的力量也意味着某种程度的义务。英国功利主义代表人物密尔（Mill）在更清晰的意义上表明了道德的义务性质。他认为，“无论是何种形式的义务，义务这一概念总是包含着，我们可以正当地强迫一个人去履行它。义务这种东西是可以强行索要的，就像债务可以强行索要一样。任何事情，除非我们认为可以强制他履行，否则就不能称为他的义务。”有义务做某事要求医务人员只有遵循相应的规范性要求，才能顺利达到医学的目标。如果违背了相关义务规范，造成了伤害，则会受到道德惩罚。可以说，义务包含了影响人们行为的“断然性意向”，具有某种程度的“命令”性质和强迫性。当然，以强迫和命令来理解义务，会片面理解道德义务的性质，强迫和命令并不能代表“义务”的存在。为此，我们必须进一步厘清义务的具体类型及相关要求。

二、道德义务与法律义务的异同

根据规范性的强弱，即保障履行的制裁力的性质和强弱上的不同，义务通常划分为法律义务和道德义务。法律义务以统治者或国家法律提供的明确而有力的制裁力为依托，履行法律义务受到国家

机器的强制约束。道德义务的规范性则诉诸社会舆论、个人良心以及风俗习惯等。总体上说，道德义务具有如下性质：①道德义务是对“应当做什么”的最终判断，故具有推翻其他义务包括法律义务的根本性；②道德判断需要通盘考虑与行动相关的理由，如行动本身的性质或后果，所以道德判断是慎思的。只有在综合考虑后确定做某事是正当的，才能为应当行为提供具有约束力的答案。因此，道德正当性与规范性之间存在可传递性，道德规范的约束力依赖于对规范要求的实质正当性的一般论证。

尽管道德义务具有根本性，但我们也不能用道德义务取代法律义务，不能取消法律规范的独立价值。由于人们个体道德观念的差异和社会文化的不同，法律需要在诸多问题中作出裁决。虽然法律义务并不具有道德判断的最终地位，但却能排除相当范围内的冲突。可以说，法律规范具有其相应的独立性。当然，由于法律的强制性特质，现代的道德规范也更多依托于法律来实施。在医学道德规范中，既有基于医学组织自身建构的道德规范，也有政府以法律法规形式颁布的道德规范。

三、医学道德规范的分类

医学道德规范根据不同的划分标准，可以有不同分类。为此，有必要介绍相关的分类情况以帮助大家理解医学道德规范的相关形态。

1. 共同医学道德规范和特定医学道德规范　共同医学道德规范适用于古今中外整个人类社会与整个医学领域，如“医学人道主义”“有利于患者”“重生”“仁爱患者”“礼遇患者”等，是古今中外人类社会所有医务人员都应该遵循的医学道德规范。特定医学道德规范适用于特定历史时期和特定的医学领域，是一定范围的医务人员应该遵守而另外范围的医务人员则无须遵守的医学道德规范；是医学界的一部分人应该遵守而另一部分人则不应该遵循的医学道德规范。根据社会发展的不同历史阶段，可以分为古代医学道德规范、近代医学道德规范和现代医学道德规范；根据不同领域，可以分为诊疗医学道德规范、护理医学道德规范、预防医学道德规范、科研医学道德规范；此外在医学的一些特殊领域，如辅助生殖、器官移植、安宁疗护、人体试验、基因技术等，则各有特定的医学道德规范。

2. 绝对医学道德规范和相对医学道德规范　绝对医学道德规范，即终极医学道德规范，是产生、决定、支配其他一切医学道德规范的标准，即医学道德目的。绝对医学道德规范只能是唯一的，因为如果是两条或两条以上，那么在它们之间发生冲突的情况下，只能遵循一条而违背另一条，永远不能违背的一条是绝对医学道德规范。相对医学道德规范是绝对医学道德规范之外的全部医学道德规范，是在某一条件下应该遵守，而在其他条件可以不遵守的医学道德规范，即只有当相对医学道德规范与绝对医学道德规范相一致时，才应该遵循；而与绝对医学道德规范相冲突时，则只能遵循绝对医学道德规范。

3. 优良医学道德规范和恶劣医学道德规范　优良医学道德规范是在一定的医学和社会背景下，具有客观必然性的医学道德规范。恶劣医学道德规范是在一定的医学和社会背景下，具有主观随意性的医学道德规范。

优良的道德规范绝非可以随意制定，而是只能通过社会明确道德目的，从人的行为事实如何的客观本性中推导、制定出来。换句话说，能否制定出优良医学道德规范，一方面取决于对医学伦理行为事实如何的客观规律的认识，另一方面取决于对医学道德目的的认识。

第二节 | 国际代表性的医学道德规范文件

自古希腊医学至今，医学道德规范经历了时代的变迁。从《希波克拉底誓言》到《新世纪的医师职业精神——医师宣言》，跨越两千余年。医学实践从区域化走向全球化，医学组织的治理机制经历了从无到有、从弱到强的进化。为应对医学实践中面临的挑战，医学道德规范也在不断修订完善。

一、《希波克拉底誓言》

约 2 500 年前，古希腊医师希波克拉底在其医疗实践中总结出来的医师职业道德规范，具有非常丰富的医学伦理思想。《希波克拉底誓言》（*Hippocratic Oath*）通常被认为是希波克拉底所作，他是医师、教师，被认为是医学之父。长久以来，“我愿尽余之能力与判断力所及，遵守为病家谋利益之信条”被广大医师反复诵读，成为宣誓者遵循的医学标准。随着医学实践的变化，誓言几经易稿，最著名的版本是 1948 年世界医学会的《日内瓦宣言》。第二次世界大战后，世界医学会肩负起为全世界设立伦理指导指南的责任。该誓言最突出的一点是强调公平对待患者：我绝不容许有年龄、疾病或残疾、信仰、种族、性别、国籍、政治立场、民族、性取向、社会地位或任何其他因素干扰我对患者的责任。20 世纪 60 年代，初始的《希波克拉底誓言》由美国塔夫茨大学医学院的勒扎纳（Lasagna）修改成现实主义版本。

世界范围内也有多种《希波克拉底誓言》的修改版本。美国采用的是 20 世纪 60 年代的改良版本，而巴基斯坦则采用原版。医师们对于毕业典礼上宣誓的回忆也各有不同，有些虽然不记得具体宣誓的内容，但仍清晰记得宣誓仪式带来的感受。宣誓对医师来说是一个非常有价值的体验。宣誓代表了医学生进入一个新阶段和职业领域，也代表了即将担负责任和他人的期望。对于原版誓言来说，最大的问题是医学在不断发展，与此同时，人们的价值观和信仰也在变化，原有的一些中心思想可能已不适用于现在。修改过的《希波克拉底誓言》依旧充满价值，如维护患者健康、尊重患者隐私等。

二、《日内瓦宣言》

《日内瓦宣言》（*Declaration of Geneva*）是在 1948 年于瑞士日内瓦举行的世界医学会（WMA）大会上被采用作为医师毕业时的宣誓誓言。此宣言为医师关于医学人道主义目标的宣誓，在第二次世界大战德国占领欧洲犯下无数医学罪行的背景下显得尤为重要。《日内瓦宣言》同样也作为《希波克拉底誓言》的现代版，将后者所包含的道德标准用现代人可以理解、适用的方式展现出来。其内容大意为告诫医师应保持良好的专业操守及向患者履行应有的责任与义务。

世界医学会成立之初就对全世界的医学伦理表示出担忧，决定撰写全世界通用的医师伦理标准。为此，世界医学会成立了一个研究委员会，负责撰写“医学职业章程”，作为全世界的医学生在获得学位时宣誓使用。经过两年的研究，委员会在 1948 年于日内瓦举行的第二次 WMA 大会上提交了一份现代“希波克拉底誓言”。经过大会批准，这份誓言被命名为《日内瓦宣言》。该宣言在世界医学会 1968 年第 22 届大会、1983 年第 35 届大会、1994 年第 46 届大会、2005 年第 170 次理事会、2006 年第 173 次理事会、2017 年第 68 届大会上进行了文字修订。相对于以往版本，2017 年修订的《日内瓦宣言》突出强调了维护患者的自主权。为突出患者自主决策在医学伦理学中的重要性，世界医学会将《日内瓦宣言》中关于患者权利的条款统一移至文件开头，而把职业责任条款放在后面。在结构上，《日内瓦宣言》增加了对医师自身的关注，在内容上对部分语句进行了增删和修改，并在细节上对部分用词进行了修改。2017 年《日内瓦宣言》的修订改进了宣言的架构，完善了宣言的内容；提高了对医师的职业要求，强调了人文关怀。

三、《国际医学伦理准则》

《国际医学伦理准则》（*International Code of Medical Ethics*，*ICoME*）也是世界医学会的代表性伦理规范。该规范于 1949 年 10 月经世界医学会第三次会议审议通过，1968 年、1983 年、2006 年和 2022 年进行过四次修订。此准则以《日内瓦宣言》为基础，根据医师对患者和同事的一般职责，确定了全世界医师的道德职责。《日内瓦宣言》与《国际医学伦理准则》均属于 WMA 体系中的规范，但也有所不同：前者属于表达承诺的公开誓言，更为严肃和庄重；后者属于准则，体现行业内部规范，凸显道德义务。1949 年版的《国际医学伦理准则》共 13 款，主要涵盖医师的一般义务、对患者的义务和对同

行的义务。由于社会的发展变迁和外部环境的新变化，医患关系日益复杂，世界医学会也在不断完善其形式，丰富其内容。如 1983 年版，首次出现了“尊重患者权利”的表述。2006 年版则首次提出“尊重人类尊严”，提出医师应该承担合理分配医疗资源的义务。随着《日内瓦宣言》于 2017 年修订更新，*ICoME* 的修订工作提上日程。2018 年，WMA 理事会成立由 19 个国家的成员和观察员组成的工作组。组长帕斯（Parsi）表示：“医师面临前所未有的挑战，它们因临床、政治、法律和市场力量的变化而不断加剧。同时，医学界在全球范围内变得越来越有活力，因此重申《国际医学伦理准则》反映的医学伦理的基础性和普遍性原则日益重要。”2022 年，世界医学会在德国柏林举行第 73 届大会，将篇幅拓展到 40 款，涵盖六部分：序言，总则，对患者的义务，对其他医师、卫生专业人员、学生和其他人员的义务，对社会的义务以及作为医疗行业成员的义务。其主要内容如下。

（一）总则方面，聚焦医师的行医要求

1. 医师的首要职责是依据良好的医疗实践和专业精神，为增进患者健康福祉提供可胜任、及时和富有人文关怀的医疗护理；在提供医疗护理时最大限度地尊重患者的生命和尊严，尊重患者的自主和权利。

2. 医师必须公平公正、凭良心、诚实正直和负责任地行医，基于患者的健康需求提供医疗护理，始终进行独立的专业判断并保持最高的专业水准。为此，医师必须为其个人的医疗决策负责，不得基于违反医疗考量的指令而改变合理的专业医学判断。

3. 医师必须尽力以最有利于患者的方式利用卫生资源。

4. 在医学上适当的情况下，医师必须参与患者或其他医师和专业人员的合作，且必须遵守保守患者秘密的义务。

5. 医师必须在职业生涯中不断学习，保持和发展专业知识技能；医师应该努力以环境可持续的方式行医，尽量减少对当代和后代的环境健康风险。

（二）对患者的义务

1. 医师必须将患者的健康和福祉放在第一位，以患者的最大利益为出发点提供医疗护理，尊重患者的尊严、自主和权利；在医疗阶段尊重患者的知情同意权。为此，医师为患者决策提供的信息应是患者理解且独立决策所需要的，医师提出的方案应获得患者自愿的同意。必须尊重具有完全民事行为能力的患者任何时候以任何理由拒绝或撤销同意的决策。

2. 即便患者决策能力受限，医师也必须让患者尽可能参与医疗决策；当无法确定患者偏好时，医师必须根据相关伦理要求基于患者最大利益作决策。

3. 紧急情况下，若患者不能决策，也无关系人在场，医师可以在没有取得知情同意的情况下，为了患者最大利益而采取干预措施。

4. 医师必须尊重患者隐私并保密，即便患者已去世。特殊情况下，当为了维护更大和压倒性的伦理义务必须披露保密信息时，医师可以披露有限必要的信息，且明确期限和接收人。

5. 医师不得让商业、经济或其他利益冲突影响其专业判断，必须保持适当的专业界限。为了提供最高标准的医疗护理，医师必须关注自己的健康、福祉和能力。

6. 采取远程医疗时，医师必须确保这种沟通形式在医学上是合理的，并提供必要的医疗护理。必须告知患者接受远程医疗的益处和局限性，征得患者的同意，并为患者保密。

（三）对同行、学生和社会的义务

1. 给予老师和学生应有的尊重。以尊重合作的态度与其他医师、同事、同行交往，遵守团队合作的伦理准则。

2. 医师在健康、健康教育和健康素养普及方面发挥着重要作用。在履行这一职责时，医师在非专业的公共场合（包括社交媒体），讨论新发现、新技术或新疗法时必须谨慎，且应确保自己的陈述在科学上是准确的、可理解的。如果医师自己的意见与循证科学信息相反，必须明确指出。

3. 医师应该避免任何削弱公众对医学界信任的行为。为了维护这种信任，医师自己和同行必须

持有最高的专业行为标准，并准备向上级报告与本准则的原则相冲突的行为。为了患者的利益和医疗卫生事业的进步，为了公共和全球健康，医师应该分享医学知识和专长。

四、《新世纪的医师职业精神——医师宣言》

医师职业精神是医学界与社会达成承诺的基础，这种承诺本质上是公众对医师个人和行业的信任。它要求将患者利益置于医师利益之上，要求制定并维护关于能力和正直的标准，并就健康问题向社会提供专业意见。医学界和社会必须清楚了解医师职业精神的原则和责任。

随着社会的发展，医学界面临着科技爆炸、市场力量介入医疗体系、全球化等挑战。医师发现越来越难以承担他们对患者和社会所肩负的责任。针对这种情况，2002 年，美国内科学委员会、美国医师学院和欧洲内科医学联盟共同发起和倡议实施《新世纪的医师职业精神——医师宣言》（*Medical Professionalism in the New Millennium: a Physician Charter*），以重申和强化医学职业精神的根本价值与普遍原则。该宣言明确提出了医学职业精神三项基本原则和十项职业责任。三项基本原则为：将患者利益置于首位；患者自主；社会公正。十项职业责任为：致力于提高专业水准；对患者诚实，为患者保密；与患者保持适当关系；不断提高医疗服务的品质；推动医疗服务的普及；对有限的资源进行公平分配；进行科学知识的创新；保证知识的可靠性；解决利益冲突而维护信任；承担本专业内部的责任。

中国医师协会于 2005 年正式签署该宣言，加入推行《新世纪的医师职业精神——医师宣言》的活动。随后，我国医学伦理学界对医学职业精神进行了系统的、卓有成效的理论研究和实践探索。

第三节 | 中国医学道德规范

我国的医学道德规范既借鉴国际伦理道德规范，又立足我国国情和社会发展的实际，体现了社会主义国家医学实践的特点。自 1988 年我国首次公布《医务人员医德规范及实施办法》后，国家教育委员会 1991 年公布了《医学生誓言（试行）》，中国科学院和中国工程院的 28 名医学界院士联名在 1996 年提出了《临床医师公约》，中国医师协会则在 2014 年颁布了《中国医师道德准则》。制定和发布这些规范的机构不同，决定了规范约束力和对象也有差别。国家教育委员会公布的《中国医学生誓言》以中国医学生即未来医师为对象，以誓言为形式。院士联名的《临床医师公约》表达的是顶尖临床医师的自律和期待，以临床医师为对象。中国医师协会的行业组织性质决定了其规范对象为所有中国医师，具有普遍代表性和权威性，体现医师行业的规范性。最具有权威性和约束力的是卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局于 2012 年联合印发的《医疗机构从业人员行为规范》。结合教学需要和医师未来执业需要，重点介绍如下三个规范性文件。

一、《中国医学生誓言》

医学宣誓仪式又叫“白大褂授予仪式”（the White Coat Ceremony）。医学誓言表达了医学生献身医学的价值观和事业信念，通过这个仪式传达“自勉与制约”的职业道德与行为规范，让医学生从穿上白大褂的第一天起，就牢记自己的义务与责任。1991 年，国家教育委员会颁布了《中国医学生誓言》，这是由中国官方颁布实施的针对医学生的习医行为规范。《中国医学生誓言》实际上吸收了《希波克拉底誓言》《日内瓦宣言》等医师誓言中的主要精神。具体内容为：

“健康所系，性命相托。当我步入神圣医学学府的时刻，谨庄严宣誓：我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。”

誓言揭示了医学的本质和医德基本理念，概括地提出了学医和行医的基本要求，成为广大医学新生入学宣誓、树立职业理想的重要信条，点燃了医学生的职业信仰之光。

二、《中国医师道德准则》

2014年6月25日，中国医师协会公布了《中国医师道德准则》（以下简称《准则》）。该《准则》明确要求医师应该处理好与患者、同行、社会及企业的关系，提出40条准则，为医师划出了道德底线。要求医师遵从行业自律，把职业谋生手段升华为职业信仰，赢得社会的尊重。它为医学职业素养培养提供了指导性价值。在最新公布的《中国本科医学教育标准——临床医学专业（2022版）》中，明确提出医师的职业精神与素养——“能够根据《中国医师道德准则》，为所有患者提供人道主义的医疗服务。”其主要内容概括如下。

1. 在总则方面　《准则》提出医师的道德要求。医师应坚持患者至上，给予患者充分尊重；敬畏生命，以悲悯之心给予患者恰当的关怀与照顾；不因任何因素影响自己的职业行为，拒绝参与或支持违背人道主义的行为；在临床实践、教学、研究、管理或宣传倡导中，承担符合公众利益的社会责任；终身学习，不断提高专业知识和技能；以公平、公正的原则分配医疗资源，使其发挥最大效益；维护职业荣耀与尊严，保持良好执业状态。

2. 在医师与患者关系方面　《准则》提出了具体规范。要求医师不因任何原因拒绝收治或歧视患者；耐心倾听患者陈述，建立相互尊重的合作式医患关系；以患者可以理解的语言或方式与之进行交流，并尽可能回答患者提出的问题；不以不实的宣传或不正当的手段误导、吸引患者；不以所学的医学知识和专业技术危害患者或置患者于不必要的风险处境；不应将手术、特殊检查和治疗前的知情同意视为免责或自我保护的举措，更不应流于形式或视为负担，而应重视与患者的沟通和宣教；医师应选择适宜的医疗措施，对于经济困难的患者尽量给予医疗帮助或协助其寻找救助途径；慎重对待患者对于维持生命治疗的选择；尊重丧失能力患者在其丧失能力之前所表达的意愿，最大限度地保护患者的权益。

3. 在医师与同行关系方面　《准则》提出了尊重、信任等要求。医师应彼此尊重，相互信任和支持；正确对待中医、西医各自的理论与实践；公正、客观评价同行医师的品格和能力，不包庇和不袒护同行，积极参与医疗技术鉴定和出庭作证等法律程序；不应相互诋毁，更不得以不正当方法妨碍患者对其他同行的信赖；应与同行相互学习与交流，并将自己的技术和知识无私地传授给年轻或下级医师。

4. 在医师与社会关系方面　《准则》提出了医师应承担的社会责任。应为急需医疗帮助的人提供适当的医疗帮助并负有专业责任；应成为公众健康的倡导者、健康知识的传播者和公众健康危险的警示者；要意识到团体、社会和环境是影响患者个人健康的重要因素。要在公共健康、健康教育、环境保护、生态平衡、社会福利以及相关立法等方面发挥积极作用；应确保所参与的项目研究符合科学和伦理道德要求。

5. 在处理医师与企业的关系方面　医师不得因医药企业的资助而进行违背科学和伦理的研究，不能为个人利益推销任何医疗产品或进行学术推广；不得参与或接受影响医疗公正性的宴请、礼品、旅游、学习、考察或其他休闲社交活动，对于企业的公益资助、临床研究或学术推广应按规定申报和说明；应当抵制医药企业假借各种名义向医师推介的处方药品搭售、附赠等促销活动。

三、《医疗机构从业人员行为规范》

《医疗机构从业人员行为规范》由卫生部、国家食品药品监督管理局和国家中医药管理局，针对医疗机构从业人员医疗服务中存在的问题而制定。其基础性文件是1988年卫生部发布的《医务人员医德规范及实施办法》，这是我国最主要的医学道德规范文件，它是医务人员医德规范的依据。《医务人员医德规范及实施办法》制定的医德规范具体内容包含七条，涉及医务人员的三个方面：前五条针对服务对象，第六条是医务人员之间的规范，第七条是医务人员的自我要求。在医患关系方面，强调医务人员救死扶伤的职责，实行社会主义人道主义，尊重患者和保护患者隐私、文明礼貌服务，廉洁奉公；在同事关系方面，强调互相尊重、团结协作；在自我要求方面，强调应该钻研医术，精益求精。制

定医德规范是为了加强社会主义精神文明，提升医务人员的道德素质，提高服务质量。由于制定主体是行政机构，它具有部门规章的约束力。

随着医药领域涉及面日益广泛，包含了食品、药品以及中医药等领域，卫生部的职能也发生改变。随着医药卫生体制改革的深化，医疗机构的规范化和制度建设工作亟须完善。2012 年，卫生部、国家食品药品监督管理局和国家中医药管理局组织制定了《医疗机构从业人员行为规范》（以下简称《行为规范》）。《行为规范》共十章，六十条，主要包含三个方面内容。

一是适用范围。《行为规范》适用于各级各类医疗机构内所有从业人员，包括：管理人员、医师、护士、药学技术人员、医技人员及在医疗机构从业的其他人员。此外，经注册在村级医疗卫生机构从业的乡村医生也适用于《行为规范》；医疗机构内的实习人员、进修人员、签订劳动合同但未进行执业注册的人员和外包服务人员等，根据其在医疗机构内从事的工作性质和职业类别，参照相应人员分类执行本规范。

二是实施与监督。为了保证《行为规范》的有效执行，按照“谁主管、谁负责”原则，《行为规范》明确由医疗机构行政领导班子负责贯彻实施，医疗机构相关职能部门协助行政领导班子抓好规范落实，纪检监察纠风部门负责对实施情况进行监督检查。

三是规范内容。《行为规范》在内容上设定了基本行为规范和每类人员的分类行为规范。以下是医疗机构所有从业人员都应当遵守的基本行为规范。

1. 以人为本、救死扶伤　坚持救死扶伤、防病治病的宗旨，秉持“大医精诚”理念，弘扬人道主义精神，以患者为中心，全心全意为人民健康服务。以人为本就是要在医疗活动中尊重人的价值，强调患者的中心地位；救死扶伤是医学服务的最高宗旨，是医务人员应该承担的基本职责。

2. 严谨求实、精益求精　严谨求实、精益求精是医务人员在学风方面应该遵循的医德规范。医学发展日新月异，社会公众的健康需求不断提高，医学模式正在由生物医学模式向“生物-心理-社会”医学模式转变。这些都需要医务人员终身学习，培养全面、高超的业务素质。

3. 平等交往、一视同仁　平等交往、一视同仁是医务人员处理医患关系时应该遵守的重要准则。平等交往是指医患双方平等相处；一视同仁是指医务人员对所有患者同等对待。这一准则可简称为“平等待患”，是对患者的权利、尊严的普遍尊重和关心，体现的是人际交往中社会地位和人格尊严的平等。

4. 举止端庄、语言文明　医务人员举止端庄、语言文明，不仅是自身良好素质和修养境界的体现，也是赢得患方信赖与合作的重要条件，有助于患者的救治和康复。希波克拉底曾提出世界上有三种东西能够治病：一是对症的药物，二是外科的手术刀，三是良好的语言。

举止端庄首先要讲究行为文明，做到态度和蔼可亲，行为稳重，动作轻盈敏捷、潇洒大方，遇到紧急情况沉着冷静、有条不紊。举止端庄还要讲究装束文明，医务人员在着装、服饰上应与职业相适应，即规范、整洁、朴素、大方，既不主观随意，又不刻意“包装”。

语言文明是指使用文明语言进行沟通。语言是人们交流思想和情感的基本工具，是体现文明修养的基本要素。医务人员良好的愿望、热情的态度、诚挚的关心，都需要通过语言来表达。因此，医务人员不仅应当规范地运用礼貌语言，还应当突出其医学特点，甚至要讲究语言的艺术性。

5. 廉洁行医、遵纪守法　医务人员在医疗活动中必须清正廉洁、奉公守法。廉洁行医、遵纪守法是古今中外优秀医家十分重视和始终坚持的医德操守。在改革开放、发展社会主义市场经济的背景下，尤其是在新旧体制交替、利益格局调整和思想观念变化的情况下，医务人员更应恪守廉洁行医、遵纪守法这一准则。

6. 诚实守信、保守医密　诚实守信是医务人员对待患者的一条普遍要求。唐代名医孙思邈在《备急千金要方·大医精诚》中，用一个“诚”字来概括和诠释“大医风范”。毛泽东在《纪念白求恩》中也曾用“诚”的精神来概括和诠释白求恩的医德境界。他说白求恩精神“表现在他对工作的极端的负责任，对同志对人民的极端的热忱”。诚实守信首先要求医者心诚，即忠诚于患者和医学事业；其

次要求言行一致，做实事、守信用。倡导和践行诚实守信准则，必须摒弃弄虚作假、背信弃义、欺诈取巧等不良医风。

保守医密是诚实守信的一个重要体现，也是西方医学的古老传统。早在2 500多年前，希波克拉底就说过："凡我所见所闻，无论有无业务关系，我认为应守秘密者，我愿保守秘密。"《日内瓦宣言》提出："我要保守一切告知我的秘密，即使患者死后也这样。"《中华人民共和国医师法》规定："尊重、关心、爱护患者，依法保护患者隐私和个人信息。"保守医疗秘密已成为我国保护性医疗的重要措施。

7. 互尊互学、团结协作　互尊互学、团结协作是正确处理同事、同行之间关系的重要准则。这一准则要求医务人员彼此平等，互相尊重；彼此独立，互相支持和帮助；彼此信任，互相协作和监督；互相学习，共同提高和发挥优势。共同维护患者利益和社会公益。

8. 乐于奉献、热心公益　随着社会的进步，人们期望医学不仅仅能治疗疾病，更能成为社会文明和人类幸福的重要支柱。乐于奉献、热心公益要求医务人员在认真完成本职工作的前提下，积极参加政府安排的抗灾救灾、应对突发公共卫生事件等医疗任务和扶贫、义诊、助残、支农、援外等社会公益性医疗活动，主动开展公众健康教育及社区保健服务，促进和改善公众的健康状况。

综上，医学道德规范是对医学实践中不同主体行为规范的抽象性概括。医学实践主体的具体性和领域的微观性，决定了它们需要将道德规范与具体实践相结合。不论是在临床诊断、治疗的一般语境下，还是急危重症患者的临床处置，抑或是针对具体的患者，都需要将抽象规范与具体语境、真实对象有机融合。

思考题

1. 医学道德规范的本质是什么？
2. 不同国际医学道德规范的核心内容有哪些？
3. 《医疗机构从业人员行为规范》的具体内容包含哪些？

（陈　化）

第五章 医学伦理原则



本章数字资源

医学伦理原则的提出和形成，源于医学实践及其发展过程。这些原则一旦确立，又对医学实践起到引导、评价、辩护和修正作用，以指导医学实践向符合医学道德要求、体现医学伦理精神的方向发展。医学伦理原则是对医学伦理规范、准则进行抽象和概括的产物，是医务人员在医疗实践中进行价值判断和行为选择的依据，也是评价医务人员行为善恶的标准。

第一节 | 医学伦理原则概述

无论是中国医学伦理指导原则还是国际医学伦理基本原则，都对医疗实践具有重要的指导意义，并且形成于医疗和社会历史实践活动中，既是医学科学技术发展的产物，也与社会文化发展密不可分。而取得人类共识的医学伦理原则一旦形成，就具有了相对的稳定性，并对医疗实践活动产生不可替代的指导作用。由于医学具有人文属性，医学伦理原则进而成为彰显人类文明进程，影响人类文明方向的重要力量。

一、医学伦理原则的含义

医学伦理原则是指医学实践活动中指导医务人员医疗行为，调节医务人员人际关系及医务人员、医疗卫生保健机构与社会关系的根本性准则，是评估医疗行为的基本原则，也是医务人员进行医疗行为选择的道德依据。

医学伦理原则可分为指导原则、基本原则和具体原则。指导原则是调节医学领域各种道德关系的根本原则，是基于医疗实践并对其具有指导意义的原则。基本原则是医疗实践活动中调节医务人员人际关系以及医务人员、医疗卫生保健机构与社会关系的基本出发点，也是衡量医务人员职业道德水平的基本尺度。具体原则是基本原则在医疗实践中的具体体现和细化。

医学伦理原则并不是对一般伦理学原则在医疗领域的简单应用，它具有自身的特殊性。这种特殊性源于医学实践的特殊性，即直接关系到人的生命健康和安全。因此，医学伦理原则首先体现医学的人道主义属性，它是在人道主义医学实践活动的基础上，不同文化传统中伦理学理论和道德原则的应用。

二、医学伦理原则产生的背景

随着医学技术的进步，引发了一系列新的伦理问题，如基因编辑、器官移植、试管婴儿等高新技术应用中的伦理难题，一些不道德的科学研究，给研究参与者造成了重大伤害，这些都促进了国际和国内医学界，开始重视医学伦理原则的制定，进而推动了医学伦理观念的发展和进步。

（一）中国医学伦理原则的提出及其历史背景

医学道德学（简称“医德学”）是医学伦理学在中国的早期学科形态。20 世纪 70 年代末期，我国医学伦理学界主要使用“医学道德”这一概念，并逐步形成了医德学的一些早期理论和思想，具有鲜明的中国特色。医德学的形成和基本理论的建构，是基于中国不同历史时期传统医学伦理文化的继承和发展，是对当时中国医学科学和技术的整体水平以及医疗卫生事业发展的总体状况的一种反映。这一阶段医德学研究和学科理论雏形的建构，为其后中国医学伦理学学科全面系统发展奠定了良好的基础。这一阶段医德学形成的多方面认识和提出的医德基本原则以及在此基础上确立的一系列医

德规范和准则等，都成为中国医学伦理学的宝贵财富。

如果从历史脉络来看，我国医学伦理原则的发端可以追溯到20世纪40年代。1941年，毛泽东同志为中国医科大学的毕业生亲笔题词："救死扶伤，实行革命的人道主义"，成为革命战争年代党领导的军队卫生人员秉持的医德精神。在此精神的感召下，卫生人员在残酷的战争环境中千方百计救治伤病员，在缺医少药的艰苦条件下想方设法诊治百姓疾患，在革命根据地创造性地开展了群众卫生运动，卓有成效地保护了人民军队的有生力量。毛泽东同志的题词也成为特定历史条件下对医学道德基本原则的精辟表述和阐释。

1949年中华人民共和国成立后，党和国家极其重视医疗卫生事业建设，医疗卫生工作的目标和方针更加明确，救死扶伤的人道主义精神在中国社会主义卫生事业建设的进程中不断彰显。1950年8月7日至19日，第一届全国卫生会议在北京举行，会议提出将"面向工农兵""预防为主""团结中西医"作为新中国卫生工作的三大方针。1952年，根据毛泽东主席"动员起来，讲究卫生"的指示，第二届全国卫生会议确立了"卫生工作与群众运动相结合"的方针。从此，"面向工农兵，预防为主，团结中西医，卫生工作与群众运动相结合"这四大方针，为新中国卫生事业的发展指明了方向。"救死扶伤，实行革命的人道主义"成为贯穿于医疗卫生工作方针中的一种鲜明的医学道德精神和原则。

1981年，全国第一次医学伦理道德学术讨论会在上海举行，会上首次明确提出了我国的"社会主义医德基本原则"。这一医学道德原则的形成反映了走上改革开放道路不久的中国社会对自身道德文化的自信。对医学人道主义原则所作的社会主义制度意义上的规定，也反映了政治伦理意识和优良医德传统在医学道德原则上的延伸和渗透，这是医学伦理学在中国发展初期所呈现出的特点。虽然与后来基于医学科学和技术的巨大进步驱使医学伦理学向生命伦理学转化的学科发展趋势有所不同，但是医德学及医德基本原则的确立，符合中国社会特定历史发展时期对医学伦理精神的需要，在中国医学伦理学发展史上的地位和价值是非常重要的。

（二）国际医学伦理基本原则诞生的历史背景

古希腊时期的《希波克拉底誓言》，12—13世纪的阿拉伯名医迈蒙尼提斯留下的祷文以及18世纪德国柏林大学教授、医师胡弗兰德的《医德十二箴》都对医师的诊疗行为提出了一系列原则性要求。随着规范伦理学的强劲发展，医疗卫生保健领域和生命科学研究领域出现了越来越多的约束医界从业人员、科研工作者的原则和规范体系。20世纪中叶以后，一系列国际医德文献相继出现，如1947年的《纽伦堡法典》确定了关于人体试验的原则；1948年的《日内瓦宣言》提出了医务人员共同遵守的行为准则；1949年的《国际医学伦理准则》明确了医师对患者和对自己的职责；1964年的《赫尔辛基宣言》提出了涉及人类受试者医学研究必须遵守的若干原则。这些伦理文献为国际医学伦理基本原则的产生奠定了重要的思想基础。

现代国际医学伦理基本原则诞生在美国和欧洲，一方面是由于医学实践以及医学科学技术发展本身对医学伦理原则的具体内容和要求产生了影响。20世纪70年代以来技术对人性的挑战尤为明显，一系列生命医学科技的发展及其所引发的道德难题促进了现代伦理学的自我变革，例如安乐死、克隆人等问题引发人们对生命、人性、权利以及社会公益等问题领域中传统道德观念的质疑和深刻反思。另一方面，在催生西方现代医学伦理学的背景中，社会发展状况是最重要的因素之一。美国学者瑞奇（Reich）提出现代伦理学是20世纪60年代变幻莫测的世界和社会运动的独特产物，是传统伦理学的新启航。他认为，需要关注催生现代伦理学的社会力量，如美国的民权运动使得患者的权利意识极大提升，世界范围的患者权利运动形成了一种建设性对话的需要。他认为，如果将现代医学伦理学的诞生归结为技术催生的结果，反而可能会导致过度运用医学方法去解决新的医学道德问题的危险，比如器官移植技术发展导致器官来源的不足引发很多伦理问题，那么生命科学界就会想方设法沿着生命科学技术路线去寻求解决问题的办法，比如开发人造器官、开展治疗性克隆的研究等。沿着医学技术的方向和专业思维方式去解决种种生命伦理问题的结果是，技术的发展可能导致新的医学道德问题不断地产生，可能会形成一种技术支配下的技术与道德间的循环。而这种过度运用的另外一

个结果，则是更加缺乏对很多由于技术发展带来的对患者或者对诸如人工流产、安乐死等临床问题的深度道德关怀。医学伦理原则的确立，与现代医学伦理学孕育和产生的社会背景有着密切关联。

1978 年 4 月 18 日，美国国家保护生物医学和行为研究受试者委员会发布了《贝尔蒙报告》（*The Belmont Report*），报告主要涉及人类受试者研究当中的保护问题，提出了尊重人（respect for persons）、有利（beneficence）、正义（justice）三个伦理原则，这被认为是西方医学伦理学界对当代医学伦理原则的最早阐释。

美国生命伦理学家恩格尔哈特（Engelhardt）首次提出二原则说，主要体现在他的《生命伦理学的基础》（*The Foundations of Bioethics*）、《生命伦理学与世俗人文主义：寻求共同的道德》（*Bioethics and Secular Humanism: The Search for a Common Morality*）等著作中。他认为允许（允诺）和行善两个原则应作为生命伦理的基本原则。

美国伦理学家蒂洛（Thiroux）在其所著的被西方称为社会伦理决策指南的《伦理学：理论与实践》（*Ethics: Theory and Practice*）一书中提出五原则说，认为生命价值原则、善良原则、公正原则、讲真话（或称为诚实）原则、个人自由原则是基本的伦理原则。虽然此学说并未直接以生命伦理学名义出现，但因其在西方具有重要地位和广泛影响，所以经常被有效地应用于解决生命医学科技伦理实践问题的决策过程之中。

1989 年，美国学者比彻姆（Beauchamp）和邱卓思（Childress）在合著的《生命医学伦理原则》（*Principles of Biomedical Ethics*）一书中提出了四原则说。他们认为，尊重原则、不伤害原则、有利原则、公正原则是生命伦理的基本原则。这一提法得到普遍认可，并被欧美等国家和地区的医学组织视为医师执业的行为依据。在与欧美不同文化背景的国家中，尽管仍对其存在争议，但还是被越来越多的国家所接受或借鉴。

第二节 | 我国医学道德基本原则

我国医学道德基本原则基于中国社会主义制度，结合医学的属性和基本目标而确定，是指导我国医疗实践的纲领性原则，并体现在我国卫生工作方针之中。

一、社会主义医德基本原则的内容

“社会主义医德基本原则”，高度概括为“防病治病，救死扶伤，实行社会主义人道主义，全心全意为人民身心健康服务。”

社会主义医德基本原则的内容，可以从相互联系的四个层次给予阐释：“防病治病”体现了“防治结合”的医疗理念，是实现社会主义人道主义的基本手段，从宏观层面指明了医学服务必须承担完整的医德责任，既要重视对患者的救治，也要重视疾病的预防工作。要求医务人员树立全面的健康观，正确认识和处理与患者个体、社会公众、生态环境的关系，承担多重责任。既要对个体生命负责，也要对社会公众负责，尤其要充分认识自身的社会责任。“救死扶伤”是临床医疗服务的首要道德职责，即所有临床医务人员都应把患者的生命和健康放在第一位，为患者谋利益。“人道主义”是医学道德的根本要求。敬畏生命、追求健康，维护生命的尊严，理解患者的痛苦，尊重患者的权利，对患者的身心健康给予极大的同情和关爱。“全心全意为人民身心健康服务”是医学道德的价值目标，医学的终极价值是为患者的身心健康服务，而实现这一价值的前提条件是从医者的全心全意。医德基本原则的这四个层次相互支撑、相互作用，是对中国古代“医乃仁术”的传统医学道德思想和现代的“白求恩精神”的一种时代性诠释。

二、社会主义医德基本原则在新时代卫生工作方针中的新体现

（一）新时代卫生工作方针的发展历程

1991 年 4 月，第七届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发

展十年规划和第八个五年计划纲要》中提到卫生工作基本方针为：预防为主、依靠科技进步、动员全社会参与、中西医并重、为人民健康服务，从而确定了我国卫生工作方针的基本框架。1997年1月，《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》出台，明确提出了新时期的卫生工作方针：以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技与教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务。

党的十八届五中全会从维护全民健康和实现长远发展出发，提出“推进健康中国建设”的新目标。为适应新形势新任务，2016年8月19日至20日在北京召开的全国卫生与健康大会上，习近平总书记提出新时代中国卫生与健康工作方针：以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享。这一工作方针既与党在不同历史时期的卫生工作方针一脉相承，又体现了新发展理念的科学内涵，具有鲜明的时代特征，是对新形势下卫生与健康工作的总要求，是推进健康中国建设和制定相关政策的基本遵循。会上，习近平总书记肯定了中国广大卫生与健康工作者弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神及在维护全民健康中作出的巨大贡献，从而确立了新时代的医德精神。

在新时代中国卫生与健康工作方针的指导下，为进一步完成“推进健康中国建设”的目标，2016年10月，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，提出以提高人民健康水平为核心，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把健康融入所有政策，全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平，显著改善健康公平的指导思想，确定“共建共享、全民健康”的战略主题，通过共建共享这一建设健康中国的基本路径，实现全民健康的根本目标。

2017年10月，党的十九大报告提出实施健康中国战略，将人民健康作为民族昌盛和国家富强的重要标志。提出要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务；倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。2020年5月22日，习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议内蒙古代表团审议时发表重要讲话，提出“人民至上，生命至上”，成为卫生健康服务的重要指导原则。2022年10月，党的二十大报告提出推进健康中国建设；把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策；坚持预防为主，提高基层防病治病和健康管理能力，重视心理健康和精神卫生，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设。2023年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持以人民健康为中心，坚持预防为主，坚持医疗卫生事业公益性，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）我国医学伦理指导原则的基本宗旨

随着国家和社会的发展，卫生工作方针在调整中不断完善，以适应卫生工作面临的新形势和新挑战。无论哪一时期的卫生工作方针，都体现了我国医学伦理指导原则的基本宗旨，即：①注重防治结合，以防病治病、救死扶伤为主要目标，通过改革创新、中西医并重、优化调整政策等手段，不断提升防病治病、救死扶伤的能力；②以弘扬医学人道主义为基本要求，坚持人民至上、生命至上的基本理念，将人民健康作为民族昌盛和国家富强的重要标志，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，体现了重视人的尊严和价值的人道主义精神；③以全心全意为人民的健康服务为价值目标，卫生健康方针的确立、健康中国战略的实施、健康中国建设的推进以及具体政策措施的制定实施，主要目标是为人民的健康服务，人民健康成为一切工作的中心和一切工作的最高价值。

第三节 | 国际医学伦理基本原则

临床医学具有普适性的专业特点，国与国之间的医学合作以及国际医学组织所推动的共同遵守的国际伦理准则和规范的广泛应用，助推了临床医学的国际化程度，也使医学伦理基本原则的确立成